第十四届“今经乐道”经济热点分析大赛

从容应队

“夕阳”产业，朝阳未来

——老年护理行业纵览与异质化破局

SILVER INDUSTRIES, GOLDEN FUTURES:
UNLOCKING THE POTENTIAL OF ELDERLY CARE

从容应队　赵晨希　易智成　李想



摘要

全球老龄化步伐加快的背景下，银发经济的崛起已成为现实。依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》及《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，**养老与健康产业于国于民意义重大，是国家战略发展之要，关乎民生福祉与经济社会和谐稳定**。因而我们认为，在银发经济的众多赛道中，**老年护理行业因处于养老和大健康两大朝阳产业的交汇点，而具备独特潜力**。因此，本研究探讨了中国老年护理行业的发展现状、挑战及未来展望，旨在找出行业发展痛点并给出优化路径。

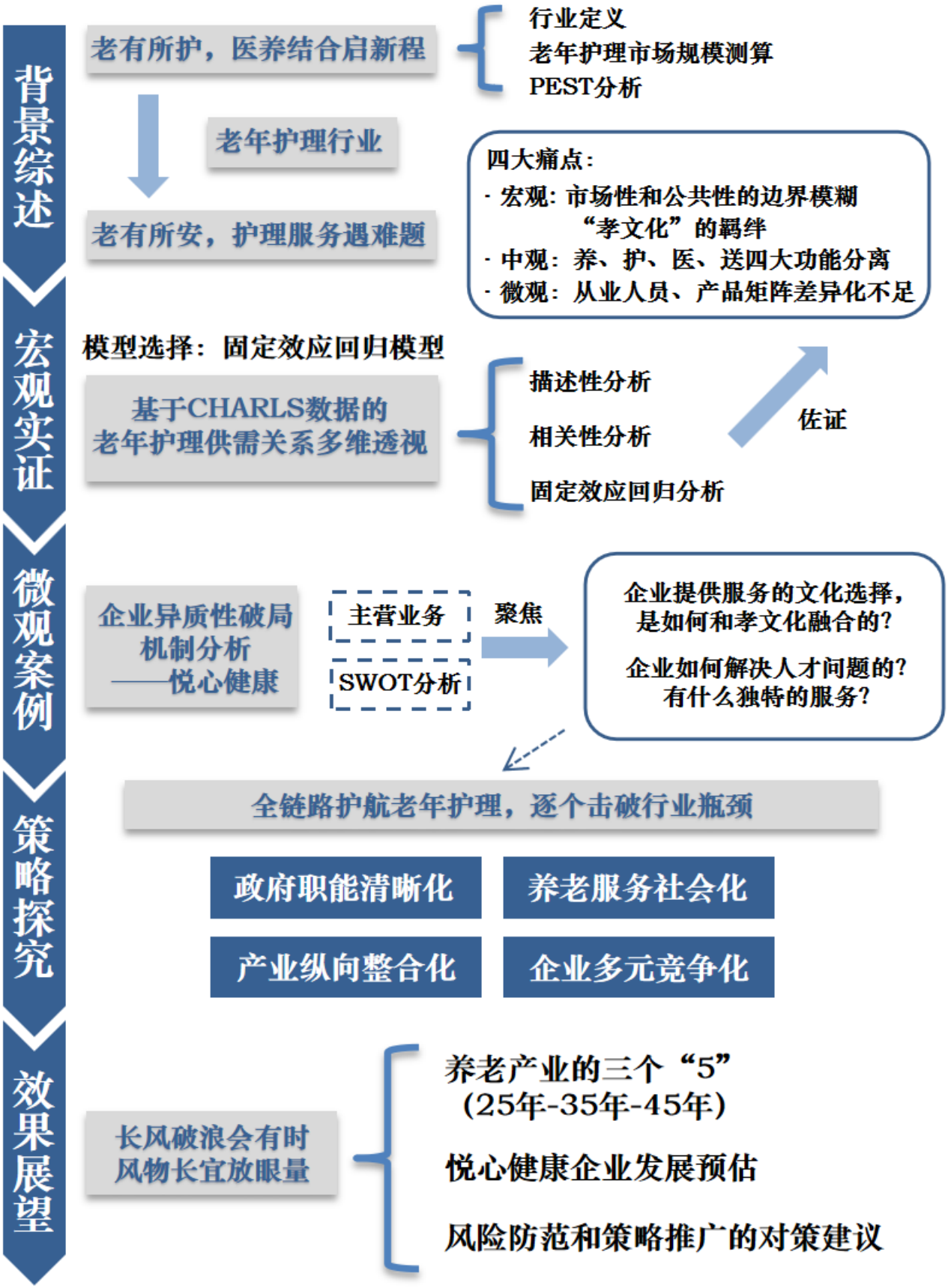
溯源行业的前世今生，我们首先通过 PEST 分析框架评估了行业目前受到的政治、经济、社会和技术因素的影响，并对老年护理行业的**潜在市场规模进行了测算**。接着从宏观、中观和微观三个层面，揭示了行业所面临的**四大痛点**，包括市场性与公共性边界模糊、孝文化的影响、“养、护、医、送”功能的分离以及护理人才和服务产品的匮乏。

为进一步论证痛点的合理性，本研究基于 CHARLS 数据库近十年数据，采用**固定效应回归模型**等方法，通过**描述性分析、相关性分析及固定效应回归分析**，探讨多个变量对老年护理需求的影响。研究发现年龄、城乡属性、教育水平、伴侣情况、性别等因素作用各异，且失能老人群体的护理需求特点突出，显示老年护理市场存在公益性和商业化补位需求，孝文化与护理供给相关，市场需差异化发展以满足不同需求，与前文总结的痛点较为契合。

为求破解之道，本研究选取行业内头部企业进行了对比分析，探讨了其异质性破局的机制。以 Python 爬取的业内上市公司年度报告词云分析为统领，从主营业务特点展开，借鉴实践经验，提出了包含 G 端和 B 端两大主体在内，共同发力的**全链路护航老年护理四大策略**。最后对策略的长期效果进行了预测，并从成本和可行性两方面评估了潜在风险。

本研究为老年护理行业的可持续发展提供了理论支持和实践指导，对政策制定者、行业从业者和学术研究者均有一定参考价值。

关键词：人口老龄化 老年护理 长期护理政策建议 机构养老


背景综述
宏观实证
微观案例
策略探究
效果展望
老有所护，医养结合启新程
行业定义
老年护理市场规模测算
PEST分析
老年护理行业
老有所安，护理服务遇难题
四大痛点：
- 宏观：市场性和公共性的边界模糊
“孝文化”的羁绊
- 中观：养、护、医、送四大功能分离
- 微观：从业人员、产品矩阵差异化不足
模型选择：固定效应回归模型
基于CHARLS数据的
老年护理供需关系多维透视
描述性分析
相关性分析
固定效应回归分析
佐证
企业异质性破局
机制分析
——悦心健康
主营业务
SWOT分析
聚焦
企业提供服务的文化选择，
是如何和孝文化融合的？
企业如何解决人才问题的？
有什么独特的服务？
全链路护航老年护理，逐个击破行业瓶颈
政府职能清晰化
养老服务社会化
产业纵向整合化
企业多元竞争化
长风破浪会有时
风物长宜放眼量
养老产业的三个“5”
(25年-35年-45年)
悦心健康企业发展预估
风险防范和策略推广的对策建议

目录

1. 背景综述——老年护理行业的前世今生与问题概述 10
1.1. 老有所护，医养结合启新程 10
1.1.1. 背景引入 10
1.1.2. 老年护理行业的定义与供需分析 12
1.1.3. 老年护理行业的市场规模测算 14
1.1.4. 老年护理行业 PEST 分析 20
1.2. 老有所安，护理服务遇难题 32
1.2.1. 宏观：市场性和公共性的边界模糊 32
1.2.2. 宏观：“孝文化”的羁绊 34
1.2.3 中观：养、护、医、送四大功能的分离 35
1.2.4 微观：企业内缺乏护理人才，服务产品矩阵欠缺差异性 37
2. 宏观实证——基于 CHARLS 数据的老年护理供需关系多维透视 37
2.1. 研究目的与变量选取 41
2.2. 描述性分析 42
2.3. 基准回归分析 43
2.3.1 模型概述 43
2.3.2 回归结果 43
2.3.3 相对重要性分析 45
2.4. 失能程度异质性分析 46
2.5. 城乡属性异质性分析 47
2.6. 实证研究总结与政策建议 48
3. 微观案例——头部企业异质性破局的机制分析 53
3.1. 战略布局：上市公司年度报告词云图（基于 python） 53
3.2. 案例聚焦 54
3.2.1. 头部企业横向对比 54
3.2.2. SWOT 分析 55
3.2.3. 公司选择：文化、人才、服务构成核心竞争力 58

3.2.4. 公司人才战略和产品矩阵创新 59
4. 策略展望——全链路护航老年护理，逐个击破行业瓶颈 62
4.1. 政府职能清晰化 62
4.1.1.畅通老年护理事业意见反馈渠道，搭建老年护理产业服务评价平台 62
4.1.2. 推动公私合作新范式（PPP） 63
4.1.3. 关注公办养老机构的“公建民营”模式 65
4.2. 养老服务社会化 66
4.3. 产业纵向整合化 70
4.4. 企业多元竞争化 72
4.4.1. 人才来源多元化 72
4.4.2. 服务产品多元化 74
4.4.3. 技术创新多元化 75
4.4.4. 服务渠道多元化 76
5. 效果预测与风险评估——长风破浪会有时，风物长宜放眼量 78
5.1. 效果展望:老年护理行业的三个“5” 78
5.2. 运作风险矩阵及可行性探讨 79
参考文献： 85

图片目录

图 1： 中国 65 岁以上人口规模及预测 10
图 2： 中国老年抚养比预测 10
图 3： 养老行业产业简析 12
图 4： 大健康行业简析 12
图 5： 老年护理需求发展时间轴 14
图 6： 老年护理供给发展时间轴 14
图 7： 中国银发经济市场规模及预测 15
图 8： 市场空间测算思路 15
图 9： 2004 年人口分年龄生活不能自理比例的结果 1（%） 16
图 10： 2004 年人口分年龄生活不能自理比例的结果 2（%） 17
图 11： 60 岁及以上老年人口的生活不能自理比例与死亡率的二次曲线关系. 18
图 12： 2020-2050 年份各年龄段老龄人口不能自理的比例..... 18
图 13： 2020-2050 年中国老年护理刚性需求测算..... 19
图 14： 2020-2050 年中国老年护理增量需求测算..... 19
图 15： 2004-2021 年 GDP 与中国康复医院、护理院、疗养院、护理站收入情况 25
图 16： 宏观经济分析：中国的四次消费升级 25
图 17： 我国恩格尔系数及城乡居民医疗保健、生活用品与服务支出情况 ... 25
图 18： 银发经济社会投资模型 26
图 19： 中国商业护理服务企业融资年份分布 26
图 20： 2014-2023 年中国商业护理服务企业融资数情况..... 27
图 21： 中国人口总数与 65 岁以上人口占比 28
图 22： 全球主要国家老龄化水平与中国对比 28
图 23： 中国人口金字塔按年龄段占比拆分（%），1950VS2023 28
图 24： 近年人均医疗保健支出 29
图 25： 近年人均医疗保健支出增幅 29
图 26： 智能家居+老年护理模式架构 30
图 27： 远程医疗+老年护理模式架构 31

图 28： AI+老年护理概念图 31
图 29： 理想状态下老年护理行业政府和市场产品边界 32
图 30： 理想状态下老年护理行业政府市场的关系示意图 32
图 31： 孝文化背景下的老年护理 34
图 32： 养老护理的价值链定位 35
图 33： 多样化的医养结合体系 36
图 34： 养老健康领域年报词云 53
图 35： 服务评价平台模式图 63
图 36： PPP 模式对养老产的支撑作用亟待提升..... 63
图 37： PPP 操作流程..... 64
图 38： 整合照护模式 70
图 39： “医康护养”共生产业系统 71
图 40： 海外企业的人力管理 72
图 41： 海外企业的员工关怀 73
图 42： 老年护理企业 16 个可能的服务产品线 75
图 43： 2019 中国设计智造大奖佳作奖便携式电动折叠轮椅..... 75
图 44： 2021 中国设计智造大奖佳作奖悠行 220 外骨骼机器人..... 75
图 45： 安康通智能工单系统 76
图 46： 柔性皮肤医疗协助机器人 76
图 47： 多元供给模式图 76
图 48： 行业发展宏观规划 79
图 49： 策略风险总览 79
图 50： 产业纵向整合化风险矩阵与可行性探讨 80
图 51： 人才来源多元化风险矩阵与可行性探讨 80
图 52： 服务产品多元化风险矩阵与可行性探讨 81
图 53： 技术创新多元化风险矩阵与可行性探讨 81
图 54： 服务渠道多元化风险矩阵与可行性探讨 82

表格目录

表 1： 各国人口老龄化情况对比 11
表 2： 养老护理产业三大功能 12
表 3： 统计局标准下养老护理行业的业务范围 13
表 4： 2025-2050 中国人口预测 16
表 5： 国务院近年发表的银发经济（老年护理）相关政策 21
表 6： 长三角地区今年老年护理业利好政策 23
表 7： 两次人口普查中家庭结构变化情况 29
表 8： 不同护理类型中 G 端参与情况 33
表 9： 2030-2050 年长期护理需求人数与长期护理人才需求量预估 37
表 10： 解释变量与被解释变量 41
表 11： 描述性统计 42
表 12： 全样本回归结果 43
表 13： 相对重要性分析 45
表 14： 失能程度异质性分析 46
表 15： 城乡属性异质性分析 47
表 16： 主要竞争对手分析 57
表 17： 他山之石——海外类似公司的业务范围 74



1. 背景综述

老年护理行业的前世今生与问题概述



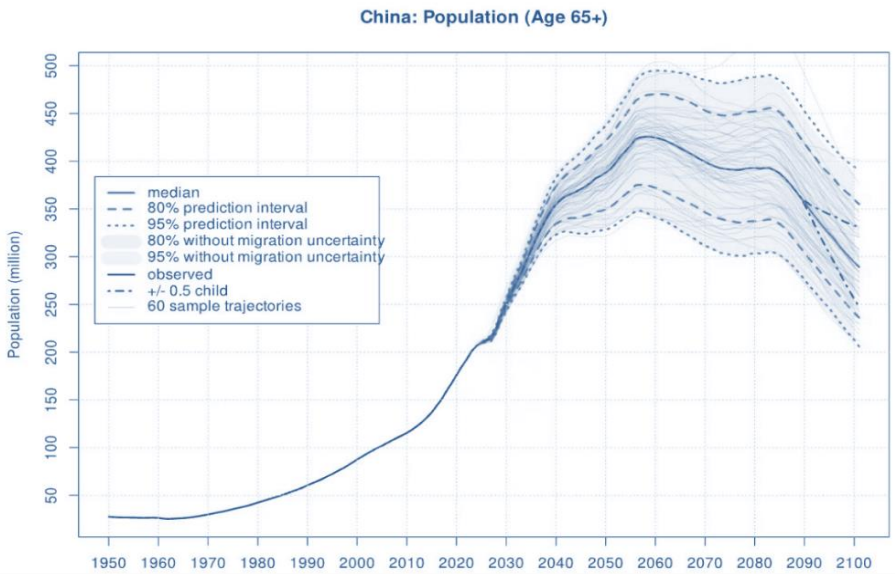
1. 背景综述——老年护理行业的前世今生与问题概述

1.1. 老有所护，医养结合启新程

1.1.1. 背景引入

在中国老年人口数量大、老龄化进程快的国情下，大力推动银发经济发展，是积极应对人口老龄化的应有之义。随着老龄化进程不断加深，消费将主导储蓄，终止了高储蓄率的时期，而这种高储蓄率长期以来推动了长期的高经济增长；并且不断增长的国家债务使得政府必须在维持养老金和医疗保健公共支出与减少预算赤字之间找到平衡[1]。这将是我国 21 世纪将要面临的重大社会问题。图 1 显示，2050 年我国将进入重度老龄化社会，65 岁以上的人口将超过 5 亿；图 2 数据表明基于联合国的《世界人口展望》中方案预测，我国老年抚养比将从 2023 年的 21.8%预计上升到 2050 年的 58.6%[5]。这意味着每两个劳动力中就有一个是老年人，甚至会超过发达国家的水平。这对一个“未富先老”的国家来说无疑是一个严峻的挑战。不过，人口老龄化也带来了经济发展和创造就业的新机遇。发达国家的实践经验表明，银发经济是老龄化社会中最具活力、最有发展前途的经济形态之一。

图1：中国 65 岁以上人口规模及预测



资料来源：2024 United Nation

图2：中国老年抚养比预测



资料来源：育娲人口

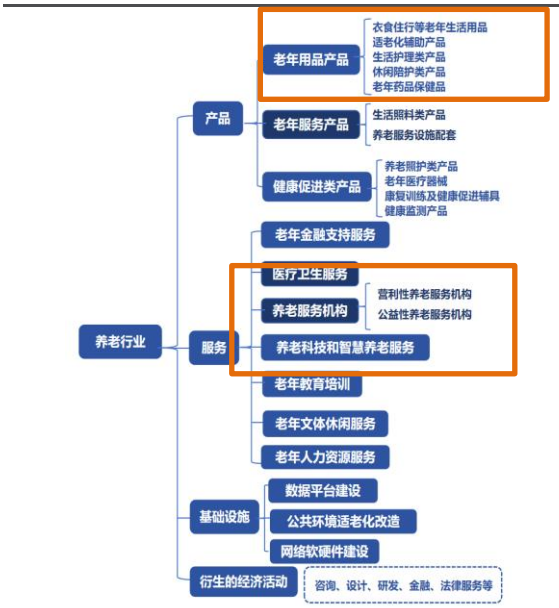
表1：各国人口老龄化情况对比

国家	老龄化程度（年）			老龄化速度（年）	
	7%	14%	20%	7%-14%	14%-20%
中国	2000	2021	2032E	21	11
美国	1941	2013	2029E	72	16
德国	1930	1971	2007	41	36
法国	1864	1990	2018	126	28
英国	1929	1975	2025E	46	50
西班牙	1947	1991	2022	44	31
意大利	1927	1988	2006	61	18
瑞典	1887	1971	2019	84	48
日本	1970	1994	2005	24	11
韩国	2000	2018	2025E	18	7
印度	2023	2048E	2063E	25	15

资料来源：联合国，国家统计局，泽平宏观。国外的预测数据来源于《世界人口展资 2022》中方案、中国的预测数据来源于育辉人口《中国人口预测报备 2023》中方案

多赛道竞争中老年护理潜力巨大。当前，发展银发经济已经成为民生顶层设计的重要举措。2024 年 1 月，《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1 号）对银发经济发展进行了具体部署，标志着银发经济发展进入新阶段。银发经济以养老服务产业为核心，围绕老年群体的衣、食、住、行、医发展支持产业，涉及老年人的各式基本与深层需求，覆盖面广、产业链长、业态多元。本研究认为，在众多赛道中，**老年护理赛道处于养老和大健康两大朝阳产业交汇点，具备独特潜力。**

图3：养老行业产业简析



资料来源：《中国银发经济刍议》彭希哲，陈倩

图4：大健康行业简析



资料来源：ifind 产业链

1.1.2. 老年护理行业的定义与供需分析

三大主要板块涵盖多种服务内容。按照国家统计局的行业分类标准，养老护理产业包括居家养老照护服务、社区养老照护服务和机构养老照护服务三大主要板块，服务对象主要是 50 岁以上的老年群体。

表2：养老护理产业三大功能

养老护理产业	居家养老照护服务	外卖送餐服务
		家庭服务
		其他居民服务业
		其他清洁服务
		社会看护与帮助服务
	社区养老照护服务	正餐服务
		快餐服务
		餐饮配送服务
		其他未列明餐饮业
		其他居民服务业
		老年人、残疾人养护服务
		社会看护与帮助服务
	机构养老照护服务	疗养院
		干部休养所
		护理机构服务
		老年人、残疾人养护服务

资料来源：统计局

三大主要板块的区分在于：

1.居家养老照护：主要由家庭成员、雇用人员以及养老服务机构等向居家老年人提供生活照料、康复护理等上门服务；

2.社区养老照护：养老服务机构依托社区设施向老年人提供日托、全托等服务，包括日间照料中心等提供的照护服务、依托社区综合服务设施和信息平台等为老年人提供的服务。

3.机构养老照护：由各级政府、企业和社会力量兴办的养老机构为集中养老的老年人提供养护和专业化护理服务，包括内设诊所等的养老机构提供的医养结合服务，以及公办和公建民营养老机构为特定老年人提供的无偿或低收费托养服务。

表3：统计局标准下养老护理行业的业务范围

大类	代码 中类	代码 小类	名称
			养老照护服务
	11	110	居家养老照护服务
	12	120	社区养老照护服务
	13	130	机构养老照护服务
	2		老年医疗卫生服务
	21	210	老年预防保健和健康管理
	22	220	老年人疾病诊疗服务
	23		老年康复护理服务
		231	老年康复和医疗护理服务
		232	老年康复辅具配置服务
	24	240	安宁疗护服务
	29	290	其他未列明老年医疗卫生服务
3			老年健康促进与社会参与
	31		老年体育健身服务
		311	老年运动休闲和群众体育活动
		312	老年体育健康服务
	32	320	老年文化娱乐活动
	33	330	老年旅游服务
	34		老年健康养生服务
		341	老年养生保健服务
		342	老年心理健康服务
	35	350	老年志愿服务
4			老年社会保障
	41		老年社会保险
		411	基本养老保险
		412	老年基本医疗保险
		413	老年长期护理保险
		414	老年补充保险
	42	420	老年人社会救助
	43	430	老年人慈善服务
	44	440	老年人社会福利
	45	450	养老彩票公益金服务

5			养老教育培训和人力资源服务
	51		养老教育和技能培训
		511	养老相关专业教育
		512	养老职业技能培训
		513	家庭护老技能培训
	52	520	老年教育
	53		养老人力资源服务
		531	养老职业技能服务
		532	养老就业服务
		533	老年人人力资源开发服务
6			养老金融服务
	61		老年商业保险
		611	老年人寿保险
		612	老年健康保险
		613	老年人意外伤害保险
		614	养老机构责任保险
	62		商业养老保险
		621	养老年金保险
		622	住房反向抵押养老保险
		629	其他商业养老保险
	63	630	养老理财服务
	64	640	养老金信托
	65	650	养老债券
	69	690	其他养老金融服务
7			养老科技和智能养老服务
	71		养老科技服务
		711	养老科学研究和试验发展
		712	养老科技推广和应用服务
		713	养老产品质检技术服务
	72		智慧养老服务
		721	互联网养老服务平台
		722	养老大数据与云计算服务
		723	物联网养老技术服务
		729	其他智慧养老技术服务
8			养老公共管理
	81	810	政府养老管理服务
	82	820	养老社会组织服务

9			其他养老服务
	91	910	养老传媒服务
	92		老年法律服务和法律援助
		921	老年司法援助服务
		922	老年公益公证服务
	93	930	养老相关展览服务
	94	940	老年婚姻服务
	95	950	养老代理服务
	99	990	其他未列明的养老服务
10			老年用品及相关产品制造
	101	1010	老年食品制造
	102	1020	老年日用品及辅助产品制造
	103	1030	老年健身产品制造
	104	1040	老年休闲娱乐产品制造
	105	1050	老年保健用品制造
	106	1060	老年药品制造
	107	1070	老年医疗器械和康复辅具制造
	108	1080	老年智能与可穿戴装备制造
	109	1090	老年代步车制造
11			老年用品及相关产品销售和租赁
	111		老年用品及相关产品销售
		1111	老年营养和保健品销售
		1112	老年日用品及辅助产品销售
		1113	老年保健用品销售
		1114	老年文体产品销售
		1115	老年药品销售
		1116	老年医疗器械和康复辅具销售
		1117	老年智能与可穿戴装备销售
		1118	老年代步车销售
	112	1120	老年相关产品租赁
			养老设施建设
	121	1210	养老设施建设、改造及装修维修
	122	1220	住宅适老化及无障碍改造
	123	1230	公共设施适老化及无障碍改造

资料来源：统计局

供需变化揭示行业未来潜力。直接改善医疗保健获取（例如，通过扩大健康保险）或关注减轻财务差异的干预通常会导致老年人的健康改善[2]，随着老年人口结构变化和社会发展，老年护理供给与需求呈现出蓬勃的发展态势[6]。国外有学者强调需要更多关注的主要老年疾病包括慢性非传染性疾病（NCDs），这些疾病是导致老年人死亡和残疾的主要原因。除了慢性非传染性疾病，心理健康障碍也是老年人群中需要关注的重要问题，包括抑郁症、焦虑症和其他心理健康问题[3]。而目前我国老年护理行业的需求从基础的生活照料逐渐扩展到更广泛的健康和精神文化层面，并且越来越注重个性化和深度服务；老年护理行业供给从家

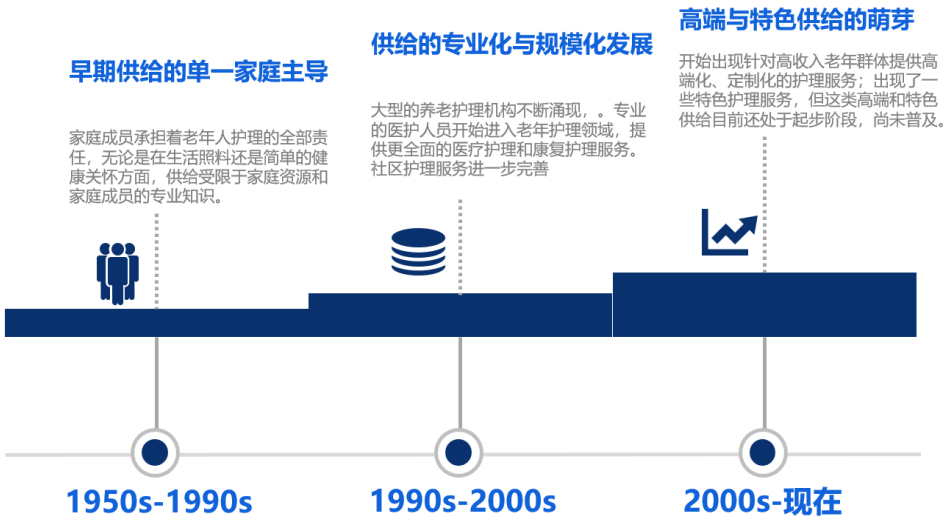
庭主导逐渐向专业化、规模化，再到高端化和特色化服务的发展趋势。

图5：老年护理需求发展时间轴



资料来源：公开资料整理

图6：老年护理供给发展时间轴



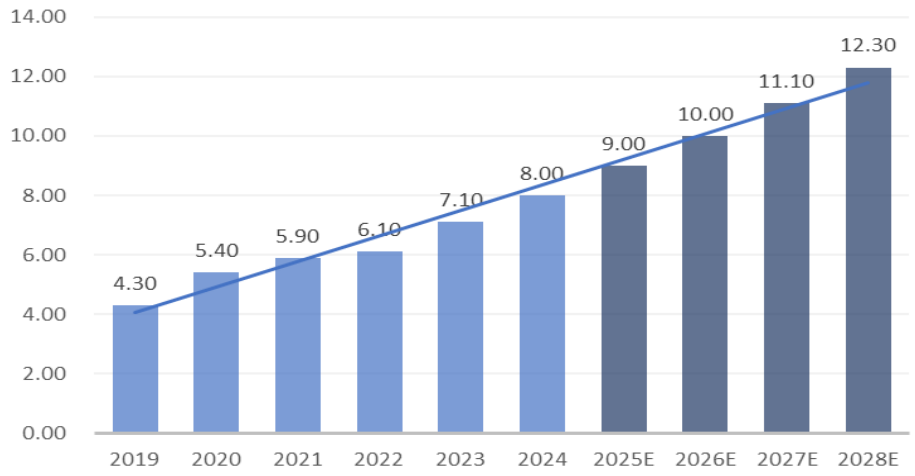
资料来源：公开资料整理

1.1.3. 老年护理行业的市场规模测算

1.银发经济总体向好，老年护理大盘扩张

以 2023 年为基准，本研究预测 2025-2028 年和 2050 年银发经济的总体规模。本研究设定了 2023 年至 2050 年的三种人均消费增长速度：高增长速度（年均增长 6%），中等增长速度（年均增长 5%），以及低增长速度（年均增长 4%）。考虑到发达国家在老龄化过程中人均消费增长速度的差异，老年群体的人均消费增长速度通常高于平均消费增长速度约 0.3 个百分点。此外，根据 2035 年人均 GDP 翻一番的规划目标，预计 2035 年 GDP 将达到 200 万亿，年均增速为 4.78%，

图7：中国银发经济市场规模及预测



资料来源：公开资料整理

我国经济的持续增长将为银发经济提供了坚实的基础。

银发经济朝 30 万亿规模跃进。经测算，本研究预计 2025-2028 年银发经济将延续稳步增长的发展态势。2028 年市场规模将达到 12.30 万亿。进一步预测，在人均消费水平中等增长速度的背景下，2050 年 60 岁以上人口的生活用品及服务消费 2.9 万亿，医疗保健消费 6.3 万亿，这些促进因素将带动银发经济朝着 30 万亿规模跃进。值得注意的是，这些预测是基于保守估计，仅考虑了老年人口的消费部分，并未包括与老龄化相关的投资，如养老设施建设和养老产业研发投入，以及居民与养老相关的金融服务和保险市场规模。若考虑到 2035 年消费对 GDP 的贡献可能达到 60%，以及相关投资和提高老年人社会经济参与度所形成的经济溢出效应，银发经济规模可能占 GDP 的 23%或更高。

总体来看，**银发经济有巨大市场潜力，为拉动内需和培育新的经济增长点提供了持久而强大的动力。**

2.测算老年护理行业潜在规模

在估计老年长期护理总费用时，本研究采用由下往上(Bottom-upapproach)估计方法：首先以国内老年人生活不能自理比例和未来老年人口发展预测估算出我国生活不能自理的老年人口数量，即老年长期护理需求者数量；再根据我国的有关经济指标获取老年长期护理需求者的年均费用支出样本，进而估算出老年长期护理总费用。

图8：市场空间测算思路



资料来源：从容应队整理

（1）我国未来人口发展预测

①数据资料的选取

基于不同生育率变化的假设。有关专家和部门对我国未来人口发展作了多方案的预测，本报告选取了由国家统计局人口与就业司预测所得的数据（2025-2050年）。

表4：2025-2050 中国人口预测

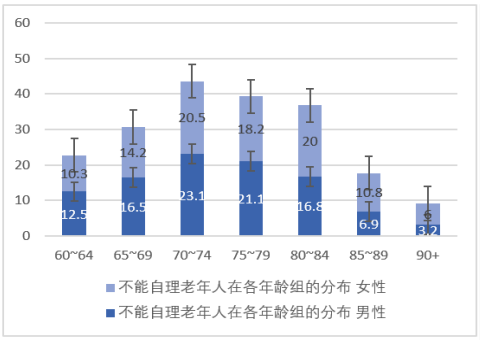
年份	总人口（万人）	人口数（万人）			出生率（‰）	自然增长率（‰）
		0~14岁	15~64岁	65+岁		
2005	130756	26961	93640	10154	12.65	5.89
2006	131537	26389	94731	10417	12.82	5.96
2007	132341	26012	95678	10651	13.07	6.09
2008	133179	25769	96551	10859	13.4	6.31
2009	134059	25688	97246	11125	13.78	6.59
2010	134985	25606	97980	11399	14.19	6.89
2011	135926	25675	98526	11725	14.34	6.94
2012	136863	25825	98931	12107	14.37	6.87
2013	137776	25986	99292	12498	14.23	6.65
2014	138646	26121	99497	13027	13.96	6.29
2015	139456	26231	99624	13602	13.59	5.83
2016	140199	26324	99747	14128	13.17	5.32
2017	140873	26390	99610	14873	12.74	4.79
2018	141477	26415	99511	15551	12.32	4.28
2019	142013	26394	99265	16355	11.93	3.79
2020	142484	26403	98943	17139	11.57	3.31
2025E	**143930**	**25224**	**99052**	**19654**	**10.2**	**1.22**
2030E	**144155**	**22766**	**97467**	**23921**	**9.77**	**-0.14**
2035E	**143860**	**21487**	**93530**	**28844**	**10.51**	**-0.56**
2040E	**143103**	**21535**	**89566**	**32002**	**10.62**	**-1.52**
2045E	**141290**	**21754**	**87085**	**32450**	**9.89**	**-3.29**
2050E	**138279**	**21068**	**84138**	**33073**	**9.18**	**-4.93**

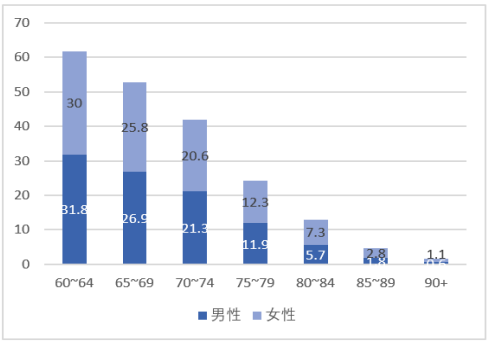
资料来源：中国未来人口发展趋势：2005～2050 年，陈卫

其次，国家统计局人口和就业统计司的《2004 中国人口》显示，中国老年人生活自理能力总体分为能自理和不能自理两类。其中，男性老年人合计中能自理的比例为 92.3%，不能自理的比例为 7.7%；女性老年人合计中能自理的比例为 89.8%，不能自理的比例为 10.2%。

图9：2004 年人口分年龄生活不能自理比例的结果 1（%）

年龄组	不能自理老年人在各年龄组的分布			各年龄组老年人占全部调查老年人的比值		岁，%
	合计	男性	女性	合计	男性	女性
60~64	11.2	12.5	10.3	30.9	31.8	30
65~69	15.2	16.5	14.2	26.4	26.9	25.8
70~74	21.6	23.1	20.5	21.3	21.3	20.6
75~79	19.4	21.1	18.2	11.9	11.9	12.3
80~84	18.6	16.8	20	5.7	5.7	7.3
85~89	9.2	6.9	10.8	2.3	1.8	2.8
90+	4.8	3.2	6	0.9	0.6	1.1



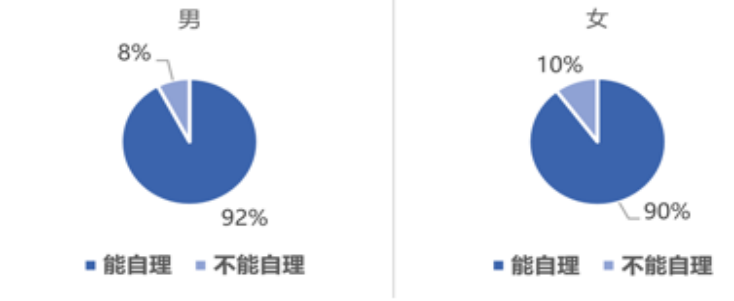


资料来源：《2004 中国人口》

图10：2004 年人口分年龄生活不能自理比例的结果 2（%）

%

生活自理能力	合计	男	女
合计	100	100	100
能自理	91.1	92.3	89.8
不能自理	8.9	7.7	10.2

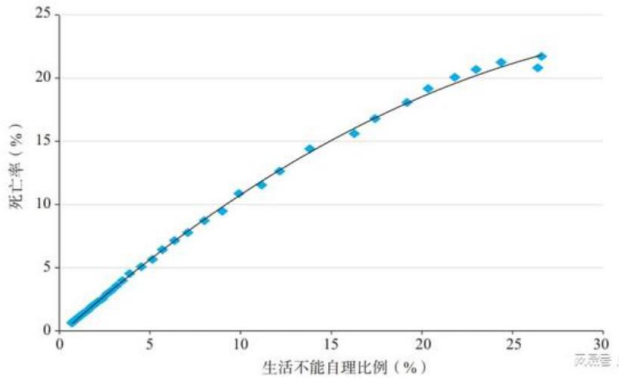


资料来源：《2004 中国人口》

六普、七普以及 2015 年全国 1%人口抽样调查数据显示，2010-2020 年，我国 60 岁及以上老年人口的健康状况持续改善，生活不能自理比例有所下降。但是，生活自理能力在老年人口中存在较强的异质性。七普数据显示，60-64 岁老年人口的生活不能自理比例为 0.8%，这一比例随年龄增长而提高，100 岁及以上老年人口的生活不能自理比例达到 31.05%，是 60-64 岁老年人口的近 40 倍。随着医疗技术的发展，未来老年人的生活自理能力将会进一步提高。基于七普数据反映的老年人口健康状况，有研究（代志新等，2023)通过七普数据发现，60 岁及以上老年人口的生活不能自理比例与死亡率高度相关，二者存在二次曲线关系。

[7]

图11：60 岁及以上老年人口的生活不能自理比例与死亡率的二次曲线关系



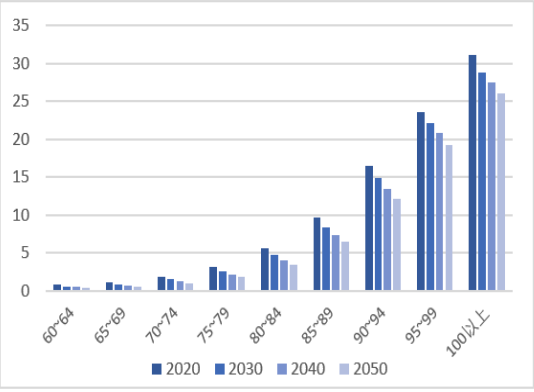
资料来源：代志新,杜鹏,&董隽含.(2023).中国老年抚养比再估计与人口老龄化趋势再审视.人口研究,47(3),94-107。根据《中国人口普查年鉴 2020》中表 6-4 和表 8-1 数据计算绘制。注：图中二次曲线拟合表达式为 y=-1.6638×2+1.2748×-0.0032，R2=0.9989

联合国《世界人口展望 2022》的中方案人口预测结果显示，未来我国老年人口的死亡率将进一步下降，且不同年龄老年人口死亡水平的下降幅度存在差异（见图 4）。相比于低龄老年人，高龄老年人死亡率下降的绝对幅度较大，但相对幅度较小。本研究按照图中的二次曲线拟合表达式，以死亡率的下降幅度来估计未来老年人口生活不能自理比例的下降趋势，进而估计及预测未来生活不能自理老年人口的规模。

基于上述统计数据，本研究预测了 2020-2050 年我国 60 岁及以上老年人口生活不能自理的比例。预测结果如表所示，到 21 世纪中叶，60-69 岁老年人口的生活不能自理比例将低于 1%，80 岁以下老年人口的生活不能自理比例将控制在 2%以内。与 2020 年相比，2050 年 80 岁及以上各年龄组老年人口生活不能自理比例的下降幅度均超过 15%。

图12：2020-2050 年份各年龄段老龄人口不能自理的比例

年龄组	2020	2030	2040	2050
60~64	0.8	0.63	0.51	0.41
65~69	1.16	0.93	0.75	0.61
70~74	1.92	1.55	1.27	1.04
75~79	3.16	2.58	2.16	1.81
80~84	5.64	4.74	4.06	3.48
85~89	9.66	8.43	7.4	6.51
90~94	16.46	14.91	13.51	12.16
95~99	23.51	22.16	20.77	19.23
100以上	31.05	28.71	27.47	26.08

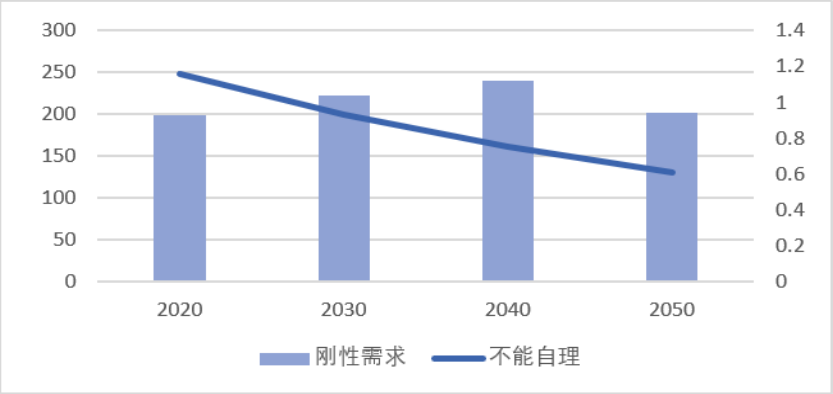


资料来源：《中国人口普查年鉴 2020》数据和联合国《世界人口展望 2022》中相关数据计算得到

国外的多数研究在估算老年长期护理需求者数量时，是以 65 岁及以上的老年人作为界限的。本研究保守估计，65 岁以上老年人不能自理的比例均为 65~69 年龄段的比例，并以此预测出我国未来老年护理刚性需求数量。

图13：2020-2050 年中国老年护理刚性需求测算

	2020	2030	2040	2050
不能自理	1.16	0.93	0.75	0.61
65+人口总数（万人）	17139	23921	32002	33073
刚性需求	198.812	222.465	240.015	201.745



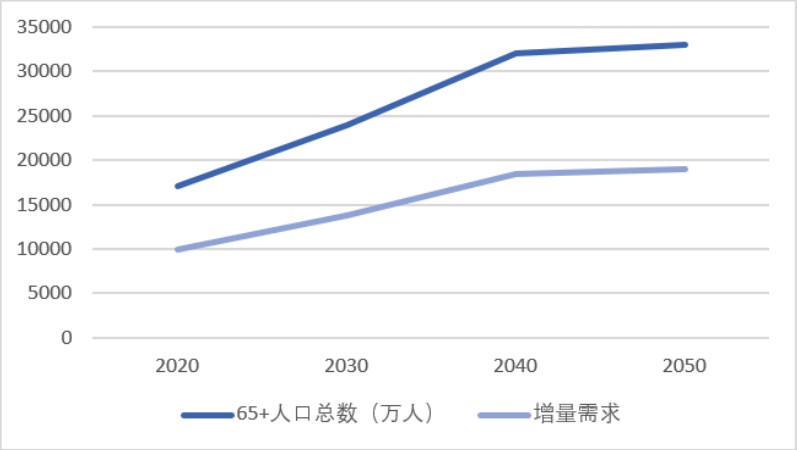
资料来源：《中国人口普查年鉴 2020》数据和联合国《世界人口展望 2022》中相关数据计算得到

世界卫生组织（WHO）2018 年公布的数据显示，65 岁以上老年人群抑郁症等心理精神类疾病的患病率，保守估计在 10~15%，甚至某些估计高达 45%。结合 CHARLS 数据库 2011 年和 2015 年数据，我国≥60 岁居民高血压、糖尿病、高胆固醇血症患病率分别为 58.3%、19.4%和 10.5%，且≥60 岁的老年人慢性病共病率较高（2011 年为 85.96%，2015 年为 92.24%）。这一部分老年人虽然具备自理能力，但对于康养领域仍存在需求。

本报告简按**老年人口数目*患病比例*0.8** 来预估老年护理行业的增量需求，其中**患病比例=[抑郁症患病比（10%）+慢性病患病比（85.96%）]*0.6。**0.6 的系数考虑了心理问题和慢性病的共发可能与收入、文化等外生变量对老年人护理需求的影响。

图14：2020-2050 年中国老年护理增量需求测算

	2020	2030	2040	2050
65+人口总数（万人）	17139	23921	32002	33073
增量需求	9867.95	13772.8	18425.5	19042.1



资料来源：《中国人口普查年鉴 2020》数据和联合国《世界人口展望 2022》中相关数据计算得到

老年护理行业市场规模庞大且增速良好，是投资的"新蓝海"。预计丧失自理能力的失能、半失能老年人护理服务渗透率约 85%[7]，具备自理能力的慢性病或抑郁问题患者以及健康群体的护理服务渗透率约 30%。同时，民政部 2011 年发布的《社会养老服务体系建设"十二五"规划（征求意见稿）中提到，2020 年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规模超过 5000 亿元。综上，本研究预测，在 2050 年老年护理产业的刚需和潜在需求将不断拉动增长，市场规模将接近 2 万亿。

事实上，这一行业的发展不仅是对人口老龄化趋势的直接回应，更是社会经济结构转型与健康观念升级的必然产物。

1.1.4. 老年护理行业 PEST 分析

1. P：政治环境--政策驱动，监管完善

> **"实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老年人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。"**
>
> **——习近平总书记**

政策驱动明显。政府近年来加大了对养老服务的投入，出台《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确提出要建立多层次、多样化的养老服务体系，支持社区养老、居家养老和机构养老的协调发展。随着对护理服务需求的增加，护理人才的短缺问题日益显著。国家卫生健康委发布的《全国护理事业

发展规划（2021-2025 年）》中提出了加快护理人才的培养和发展；卫生部与教育部共同组织、制定的《护理、药学和医学相关类高等教育改革和发展规划》鼓励高等院校设立护理学专业，并根据市场需求调整课程设置，加强实践教学。政府对参与养老服务的企业提供税收优惠和财政补贴，以鼓励社会资本进入老年护理市场，提升服务质量和服务能力。国家逐步完善养老保险制度，提升老年人的经济保障水平，使得更多老年人能够承担护理服务的费用，进而促进市场的健康发展。

表5：国务院近年发表的银发经济（老年护理）相关政策

国务院	
2022	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》
2020	《关于促进养老托育服务健康发展的意见》 《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》
2019	《关于推进养老服务发展的意见》
国务院部门	
养老机构重大事故隐患评定标准	
2024	《关于加快发展农村养老服务的指导意见》 《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》 《关于开展 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目成果验收的通知》 《关于组织开展基本养老服务综合平台试点的通知》 《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》
2023	《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 《养老机构重大事故隐患评定标准》 《养老和家政服务标准化专项行动方案》 《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》 《进一步改善护理服务行动计划（2023—2025 年）》 《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》
2022	《关于开展 2021 年居家和社区基本养老服务提升行动项目成果验收的通知》 《关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见》 《关于组织开展 2022 年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作的通知》 《养老机构行政检查办法》 《关于做好 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》 《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》 《全国护理事业发展规划（2021-2025 年）》

关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知	
2021	《关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知》 《关于推进养老机构“双随机、一公开”监管的指导意见》 《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》 《关于组织实施 2021 年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》 关于做好《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》贯彻落实工作的通知 关于开展居家和社区养老服务改革试点工作总结推广改革试点典型经验的通知 《长期护理失能等级评估标准（试行）》
2020	住房和城乡建设部等部门关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见 关于加强养老机构新冠肺炎疫情常态化精准防控及应急处置工作的通知 养老机构管理办法 关于开展第四批居家和社区养老服务改革试点成果验收的通知 关于做好 2020 年养老院服务质量建设专项行动工作的通知 关于及时调整完善疫情防控策略 有序恢复养老机构服务秩序的指导意见 《养老服务智能化系统技术标准》 关于分区分级精准做好养老服务机构疫情防控与恢复服务秩序工作的指导意见 《新冠肺炎疫情高风险地区及被感染养老机构防控指南》 《养老服务体系建设中央补助激励支持实施办法》（2020 年修订版） 关于确定第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知 《养老机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指南（第二版）》 关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见 关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见 关于进一步加强医疗机构护理工作的通知 药事管理和护理专业医疗质量控制指标（2020 年版） 关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知

资料来源：国务院官网

近年来，随着人口老龄化进程的不断加快，老年护理行业的重要性愈发凸显，与之相关的区域性支持政策也呈现出日益高涨的态势。各地方政府深刻认识到老年护理对于保障老年人生活质量、减轻家庭养老负担以及推动社会和谐稳定发展所具有的关键意义，纷纷结合本地区的实际情况与发展需求，加大在老年护理行业的政策扶持力度。无论是在财政补贴方面，对老年护理机构的建设、运营以及专业护理人员的培训给予充足的资金支持；还是在场地规划上，优先为老年护理相关设施预留合适的土地资源，并在审批流程上予以简化和加快；亦或是在人才培养与引进政策上，通过与高校、职业院校合作定向培养专业人才，同

时制定优惠政策吸引外地优秀老年护理人才流入本地，都彰显出区域性支持政策在老年护理行业的推动作用与积极影响，为老年护理行业的蓬勃发展注入了强劲动力，也为广大老年人能够享受到更加优质、专业、贴心的护理服务奠定了坚实基础。从容应队聚焦长三角地区收集近 3 年 老年护理行业强相关利好政策如下所示：

表6：长三角地区今年老年护理业利好政策

上海市	
2024	《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024—2027 年）》
2023	《上海市城乡居民基本养老保险办法》
2022	关于加快本市康复辅助器具产业发展的实施意见 《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》 《上海市老年照护统一需求评估及服务管理办法》 《进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案》 《上海市养老服务设施布局专项规划（2022—2035 年）》
2021	《上海市养老服务机构综合监管办法》 关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见 《上海市老龄事业发展“十四五”规划》
江苏省	
2024	省政府办公厅关于印发促进银发经济高质量发展实施方案的通知 省政府办公厅关于印发进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知
2023	省政府关于推动养老事业和产业发展提升养老服务质量的实施意见
2021	省政府办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见 省政府办公厅关于促进养老托育服务高质量发展的实施意见 省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”养老服务发展规划的通知 省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”老龄事业发展规划的通知
浙江省	
2024	《浙江省养老机构等级评定管理办法》和《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》 《浙江省推进存量资源改建养老服务设施操作办法（试行）》
2023	浙江省人民政府办公厅关于加快建设基本养老服务体系的实施意见
2021	浙江省人民政府办公厅关于加强养老服务综合监管促进养老服务高质量发展的实施意见 浙江省卫生健康委员会关于深化“互联网+ 护理服务”提升居家护理服务质量的通知 《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》 《浙江省养老服务补贴制度实施办法》 《浙江省养老服务专业人员入职奖补办法》 《浙江省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》

2020	《浙江省养老机构等级评定管理办法》 《浙江省养老机构等级评定工作实施细则》
安徽省	
2024	《安徽省失能老年人健康服务行动（2024-2027 年）实施方案》
	《加强社区嵌入式养老医疗卫生服务保障工作举措》
	《安徽省老年助医行动服务举措（试行）》
2023	《安徽省养老机构等级评定管理办法》和《安徽省养老机构等级评定评分细则》 关于组织开展 2023 年安徽省老年健康宣传周活动的通知 《安徽省养老机构备案管理办法》 《安徽省进一步推进医养结合发展行动方案》 《健康养老基地建设指南 DB/34T 4357—2022》 关于加快促进养老产业发展的意见 《养老服务培训基地建设指南 DB 34/T 4356—2022》
2022	《安徽省推进基本养老服务体系建设实施方案》
	《安徽省养老服务条例》
	关于做好免收民办非营利性养老服务机构房租工作的通知
	《养老机构服务纠纷处理规范 DB34-T 3749-2020》
	《安徽省“十四五”护理事业发展规划》
	《养老机构疫情防控期间护理服务指南》
2021	《安徽省健全基本养老服务体系促进养老服务高质量发展行动计划（2021—2023 年）》 《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的若干措施》 老年医疗护理服务试点工作方案 安徽省“互联网+护理服务”试点工作方案
2020	安徽省进一步加强医疗机构护理工作实施方案
	安徽省加快老年护理服务发展工作方案

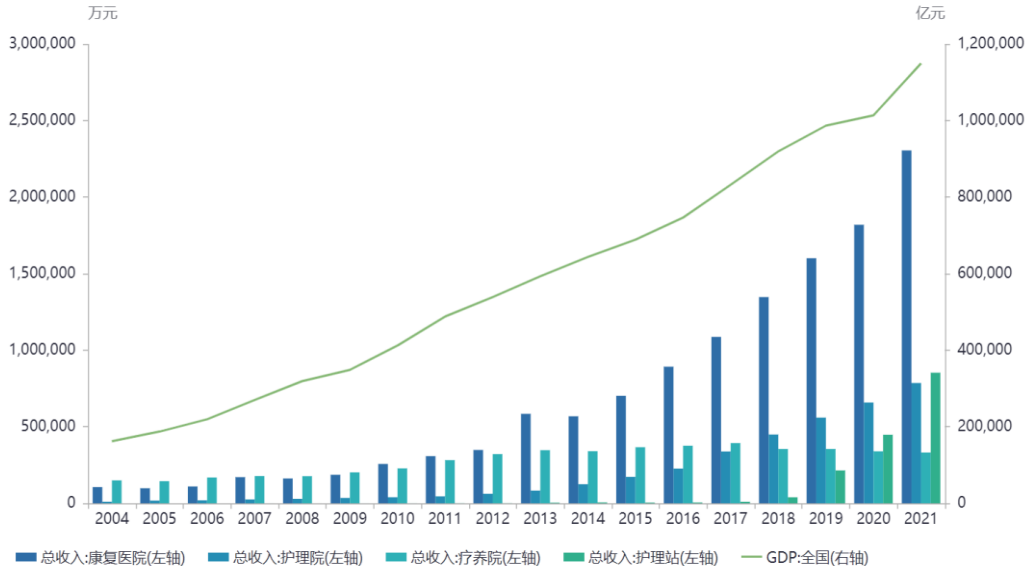
资料来源：地方政府官网

2.E：经济环境--宏观向好，投资机遇丰富

> **“经统计，截止 2018 年 9 月，财政部 PPP 中心项目库中（含项目管理库、项目储备清单），共有养老类项目 210 个，总投资 1639.88 亿元。其中项目管理库中养老类 PPP 项目共 106 个，项目总投资 819.81 亿元；项目储备清单含有养老 PPP 项目 104 个，项目总投资 531.53 亿元。”**
>
> **——国家财政部**

宏观经济稳定增长，提供坚实经济基础。家庭收入水平的提高使得人们在老年护理方面的支付能力增强，社会资本也更愿意投入到养老产业中的老年护理行业，进而促进了老年护理机构的建设、设施设备的更新以及护理服务质量的提升。

图15：2004-2021 年 GDP 与中国康复医院、护理院、疗养院、护理站收入情况



资料来源：ifind 数据库

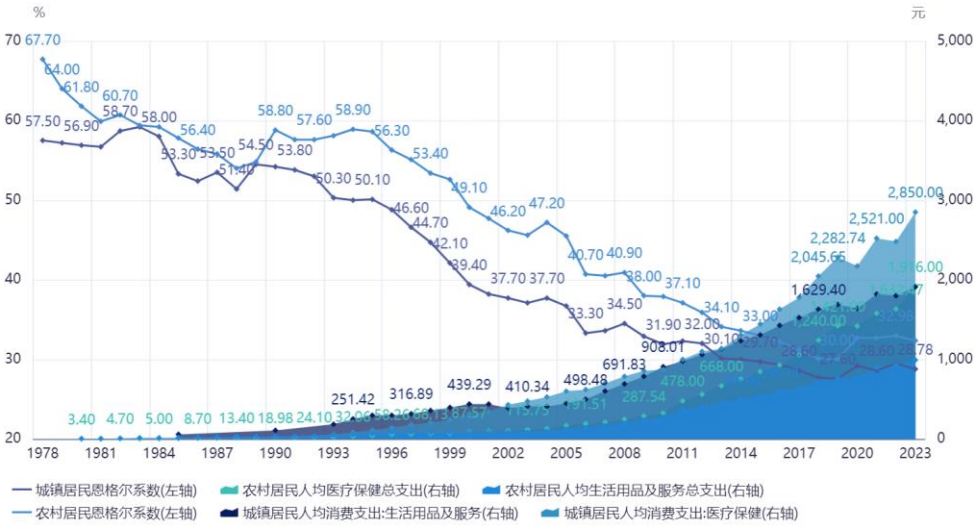
居民消费结构升级推动老年护理高端化、专业化。国家统计局发布“党的十八大以来经济社会发展成就系列报告之十九”指出，党的十八大以来，各地区各部门认真落实扩大居民消费的各项政策措施，国内发展消费结构优化升级，发展型享受型消费日益提升，服务性消费支出占比逐步提高。2021 年全国居民人均医疗保健支出 2115 元，比 2012 年增长 152.3%，年均增长 10.8%，快于全国居民人均消费支出年均增速 2.8 个百分点，占人均消费支出的比重为 8.8%，比 2012 年上升 1.8 个百分点。消费结构的升级意味着人们对老年护理的消费观也发生了变化。消费者不再满足于基本的生活照料服务，而是愿意为更高质量、更多样化的护理服务付费，如高端的养老社区、个性化的康复护理服务等。

图16：宏观经济分析：中国的四次消费升级



资料来源：正和岛，从容应队整理

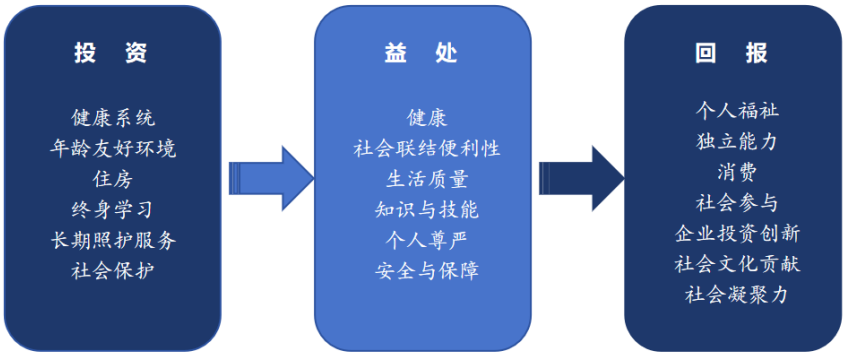
图17：我国恩格尔系数及城乡居民医疗保健、生活用品与服务支出情况



资料来源：国家统计局

投资窗口明显，融资逐步启航。截至 2022 年 12 月 19 日，护理行业共发生投融资事件 324 起，其中 A 轮投资事件最多，达到 130 起，其次为种子天使，达到 97 起。2022 年 1-12 月共发生 11 起投资事件，其中下半年已披露投资金额最大的事件为集群车宝收到的 D 轮投资，金额达 5000 万美元。从企业类型看，获得融资的企业中，大多数业务模式都是居家护理，总体偏“轻”，融资额普遍在千万级。

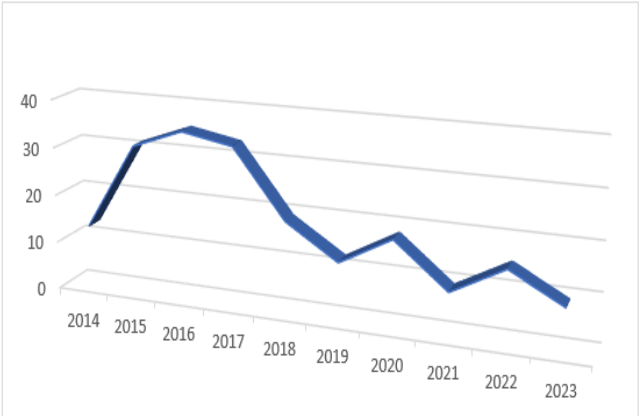
图18：银发经济社会投资模型



资料来源：CaroleGordon.4SiherEconom.ThelahseofLivingLonger.SUPA.NZ.2017.

图19：中国商业护理服务企业融资年份分布

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
数量	13	31	35	33	19	12	18	9	15	9

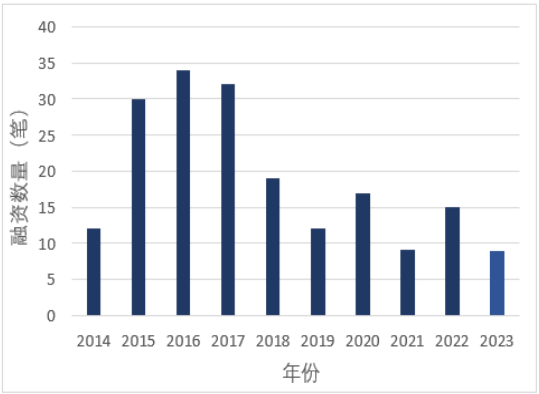


资料来源：企查查，蛋壳研究院，从容应队整理

虽然现阶段银发经济产业具有**高投资、长周期、低利润**的特征，企业、机构容易面临**用地难、用工难、融资难、营利难**等具体问题。但长期的投资热情正在形成，投资主体朝着多元化发展，社会资本投资动力逐步加强。

图20：2014-2023 年中国商业护理服务企业融资数情况

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
融资数量（笔）	12	30	34	32	19	12	17	9	15	9



资料来源：公开资料，华经情报网，从容应队整理

2. S：社会环境--社会转变，需求激增

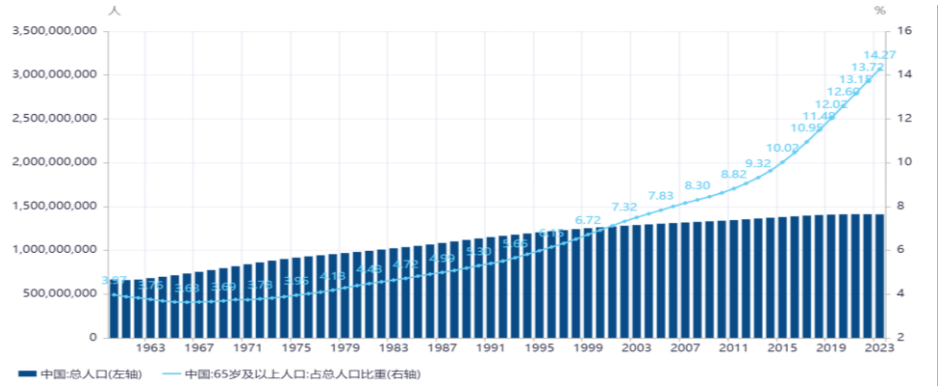
> “全世界都意识到现在老年保健严重不足。本研究只在河流的下游去解决问题，生病了，本研究去治病，这个办法是不灵的，所以一定要从上游解决问题，怎么让老年人更加健康，更加积极的老龄化。”
>
> ——北京大学教授张拓红

人口老龄化情况加剧，老年健康护理需求增大。

从容应队——夕阳产业，朝阳未来

老年人口规模庞大。预计到 2035 年左右，60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，在总人口中的占比超 30%，中国将进入重度老龄化阶段。2057 年中国 65 岁以上人口达 4.25 亿人的峰值，占总人口比重 32.9%-37.6%。

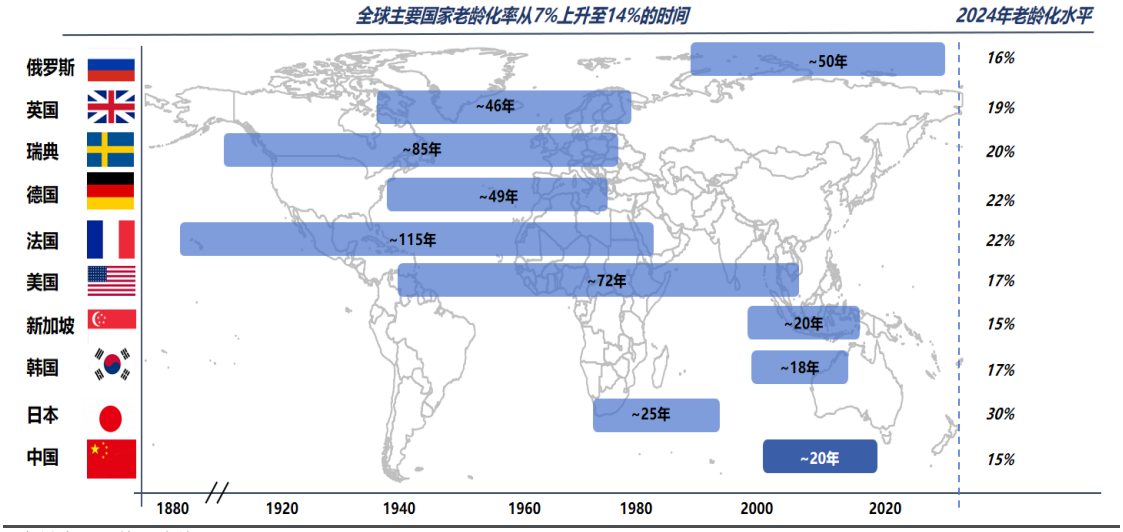
图21：中国人口总数与 65 岁以上人口占比



资料来源：国家统计局，ifind 数据库

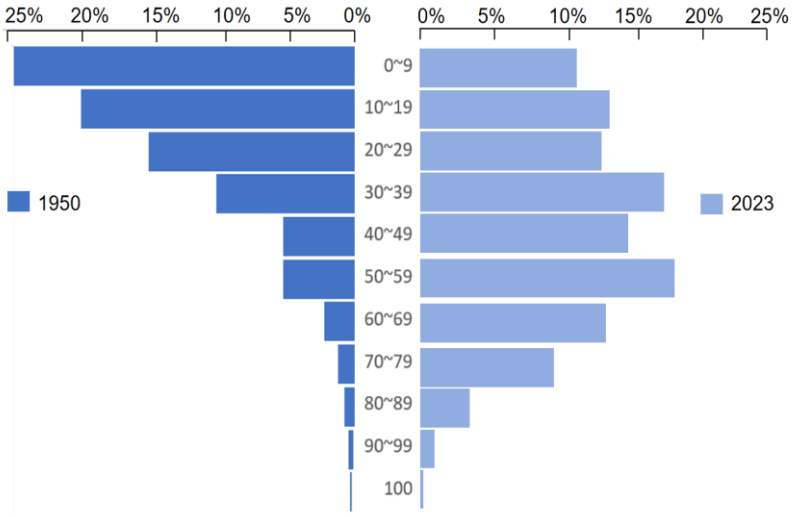
老龄化速度快。北京大学人口研究所所长陈功认为，中国仅用 21 年就步入深度老龄化，时间短于法国的 126 年、英国的 46 年、德国的 40 年。在 2021 到 2030 年间，劳动年龄人口总量和比例将继续以较快速度降低，人口抚养比也将继续提升，由低人口抚养比带来的人口数量红利逐步进入尾声。随着第二次生育高峰出生的“60 后”群体步入退休年龄，老年人口增长速度将明显加快，到 2030 年占比将达到 25%左右，其中 80 岁及以上高龄老年人口增加幅度更加明显。

图22：全球主要国家老龄化水平与中国对比



资料来源：灼识咨询

图23：中国人口金字塔按年龄段占比拆分（%），1950VS2023



资料来源：联合国，弗若斯特沙利文

家庭结构渐趋小型化，家庭养老功能不断弱化。第七次全国人口普查(“七普”)显示，2020 年中国（大陆地区，下同）平均家庭户规模为 2.62 人，已跌破“三口之家”的最基本数量底线。子女数量减少、工作压力增大等因素使得家庭在老年护理方面面临更多的困难。这促使更多的老年人寻求社会养老和专业老年护理服务，潜在推动老年护理行业的发展。

表7：两次人口普查中家庭结构变化情况

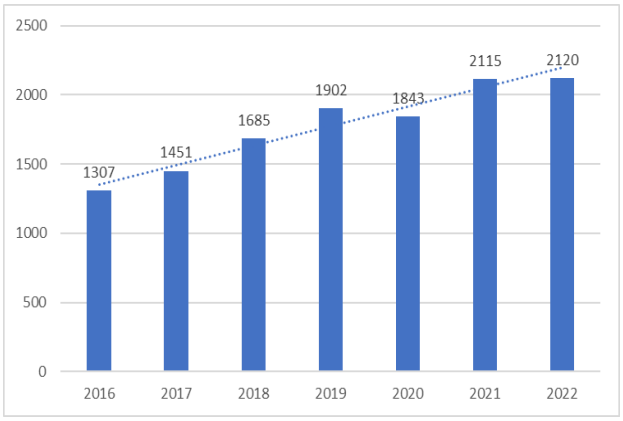
家庭结构/普查年份	家庭户户主			家庭户成员		
	1982	2020	变化	1982	2020	变化
1 核心家庭	68.7	55.3	-13.4	65.3	53.5	-11.7
（1）夫妻核心家庭	4.8	21.8	17	2.1	15.1	13
（2）标准核心家庭	51.4	26.5	-24.9	54.1	31.9	-22.1
（3）缺损核心家庭	12.6	7.1	-5.5	9.1	6.5	-2.6
2 扩展家庭	22.9	24.2	1.3	32.4	38.6	6.2
（1）三代直系家庭	15.6	14.7	-0.9	21.5	25.6	4.1
（2）其他扩展家庭	7.3	9.5	2.2	10.9	13	2.1
3 单人户	8.4	20. 5	12.1	2. 4	7.9	5.5
合计	100	100	0	100	100	0

资料来源：王磊《中国家庭结构变迁的特征趋势与问题研究——基于全国人口普查微观数据的分析》

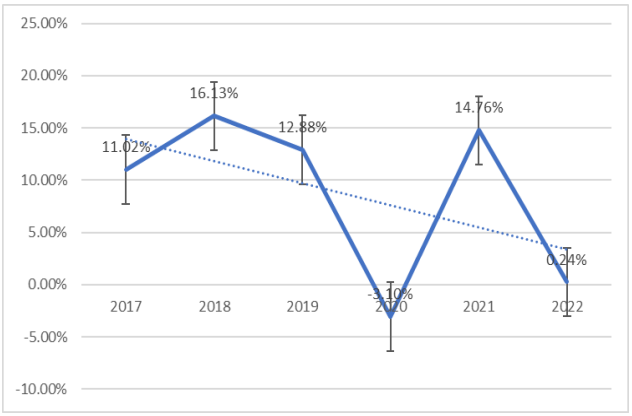
医疗保健需求持续增长。国家统计局数据显示，我国人均医疗保健支出总体呈上升趋势，2019 年前增幅稳定在较高水平，之后略有回落，但总体上呈显著增长趋势。2021 年，人均医疗保健支出已突破 2000 元。

图24：近年人均医疗保健支出

图25：近年人均医疗保健支出增幅



资料来源：国家统计局



资料来源：国家统计局

4.T：技术环境--技术突破，研究发展

> **“利用人工智能技术，不仅可以提高护理服务的效率和质量，还能通过智能设备远程监测老年人的健康状况，及时预警潜在的健康风险，这对于提升老年护理服务水平至关重要。”**
>
> **——复旦大学老龄研究院银发经济发展研究中心主任封进**

技术创新应用如火如荼，明星产品崭露头角。国外学者指出，在技术或治疗层面，关注现代技术以抵消衰老的负面影响。机器学习、大数据和其他新技术也可以用来监测人口层面的疾病模式，并可能用于未来的政策设计[4]。当下中国的老年护理业正在积极探索创新技术的应用，具体包括：

1.智能家居技术的应用：

智能监控、语音助手助力老年人居家安全。先进的毫米波雷达设备可安装在卧室和卫生间，做到跌倒实时报警，第一时间告知子女，防止卒中、心梗或者摔倒无法及时救治而带来的严重后果。北京市石景山幸福颐养护理院定制了小米科技生态智能适老家居系统，包括智能检测床垫、智能照护系统等，有效提升了护理服务的质量和效率。

图26：智能家居+老年护理模式架构

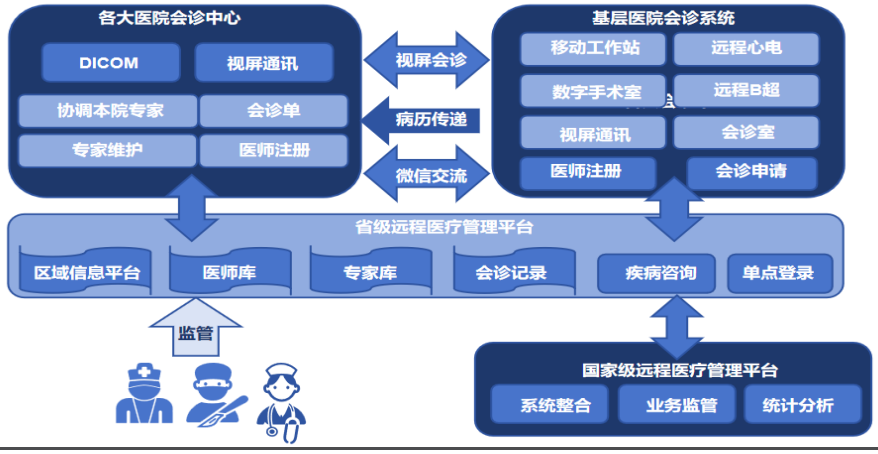


资料来源：公开资料

2.远程医疗服务的发展：

视频通话、在线诊疗赋能专业健康指导。针对老年人使用智能手机的难题已有机构参照工信部适老化设计标准研发了适合老年人使用的大图标、高对比度的医养服务老年人端 App，支持语音输入、语音命令，并让老年人端和家庭端 App 形成联动，让子女协助输入老年人相关医疗健康档案并共享。

图27：远程医疗+老年护理模式架构

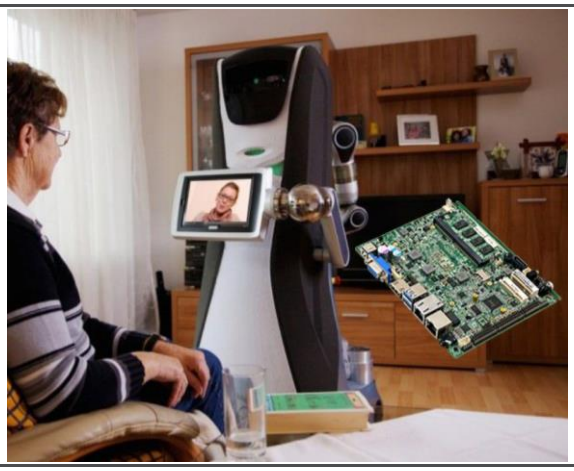


资料来源：HIT 专家网，从容应队整理

3.人工智能、数据分析与管理系统的辅助应用：

人工智能技术依托康养系统设备打造个性化健康养老方案。中新天津生态城在市级平台基础上，采用“1+2+6+N”体系架构，即 1 个 AI 银发智能服务平台、智能语音和大数据分析 2 项核心能力、提供主动关怀、健康管理、随身监护、生活服务、应急保障、AI 热线 6 大服务、提供 N 个针对老年人需求的精细化应用。

图28：AI+老年护理概念图



资料来源：公开资料

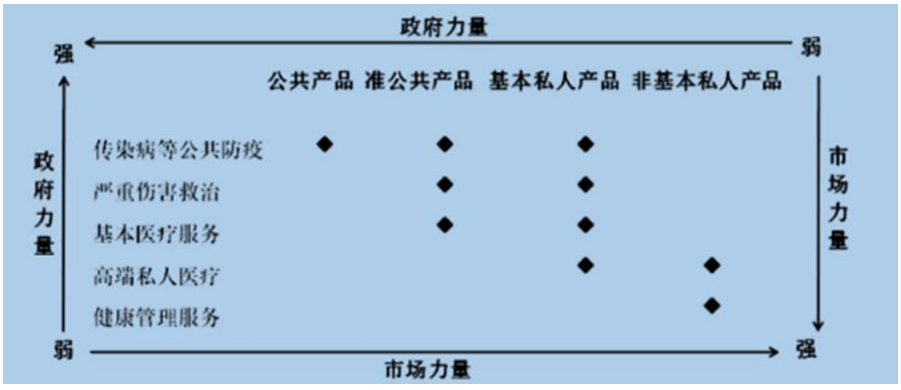
政策、老年护理、药物开发、个人意识、大数据使用、机器学习和精准医疗等领域的跨学科合作，将使中国成为一个在未来几十年内为老年人提供最多支持的国家，最大化并庆祝他们的长寿[3]。

1.2. 老有所安，护理服务遇难题

1.2.1. 宏观：市场性和公共性的边界模糊

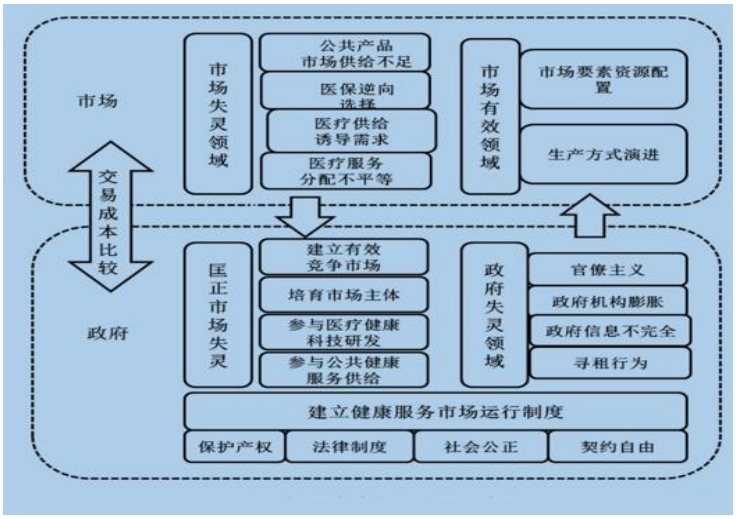
养老服务产业体现了市场性和公共性的结合。养老服务产业不是由政府举办的免费福利，也不是一种公益事业，而是建立在市场经济之上的产业，必须实现营利性。同时，养老服务与老年人的生活福祉息息相关，对所有老年人提供的基本公共养老服务，以及对贫困老年人的养老服务，均需要由社会保障制度承担。**如何保障各类老年人的多种服务需求，使“市场性”与“公共性”实现较好的融合，就成了政府与养老服务组织需要共同面对的问题。**

图29：理想状态下老年护理行业政府和市场产品边界



资料来源：《健康中国战略下的健康服务供给模式优化研究》刘艳飞 胡晓辉

图30：理想状态下老年护理行业政府市场的关系示意图



资料来源：《健康中国战略下的健康服务供给模式优化研究》刘艳飞 胡晓辉

对比图 29、30，目前中国的老年护理服务体系中存在越位、缺位、错位等问题，市场性和政府性的边界始终不清晰，主要表现在以下几个方面:

1.没有完全做好老年护理服务“事业”与“产业”的区分，G 端参与不明晰。一些地方公办养老机构向一般社会老年人开放，偏离了政府“保基本、保困难、兜底线”的方向，没有做到“雪中送炭”，反倒为富裕老年人养老“锦上添花”；而面对居家护理、社区护理等 G 端参与颇显乏力。

表8：不同护理类型中 G 端参与情况

护理类型	付费模式	主要服务对象	优点	不足
院内护理	C端付费 少量B端付费	疾病急性期住院患者	发展相对成熟 刚性需求	服务质量和内容待升级
居家护理	G端付费 少量C端付费	慢性病患者、老年人 母婴群体	市场天花板高 是商业护理主流模式	标准化难度更大 服务质量更难把控
社区护理	G端付费 极少量C端付费	慢性病患者、老年人	价格低廉、服务便捷 上门服务	高度依靠G端 服务内容较基础
机构护理	C端、G端、B端付费	失能、半失能老人	服务高端	价格高昂，供需不匹配

资料来源:从容应队整理

2.政府多头管理，政策扶持落实难。普通养老机构归民政部门管理，社区居家养老服务由老龄办组织，医疗卫生机构归卫生部门管理，医保报销由社保部门管理，存在职责交叉情况。由普通养老机构转型的，有机会获得政府一次性建设财政补贴和运营补贴，但由医疗机构直接转型的却得不到任何补贴。“多头管理”或“多头不管”的局面使各部门对各项扶持政策的认识、调整和落实难以做到协调一致和横向整合。如合肥市拟建民办养老机构申报土地划拨时，政府不审批或者拖延审批的现象普遍，床位补贴过低、不及时。

3.老年护理收费尚未市场化：现行的护理收费定价标准过低，如北京市公立

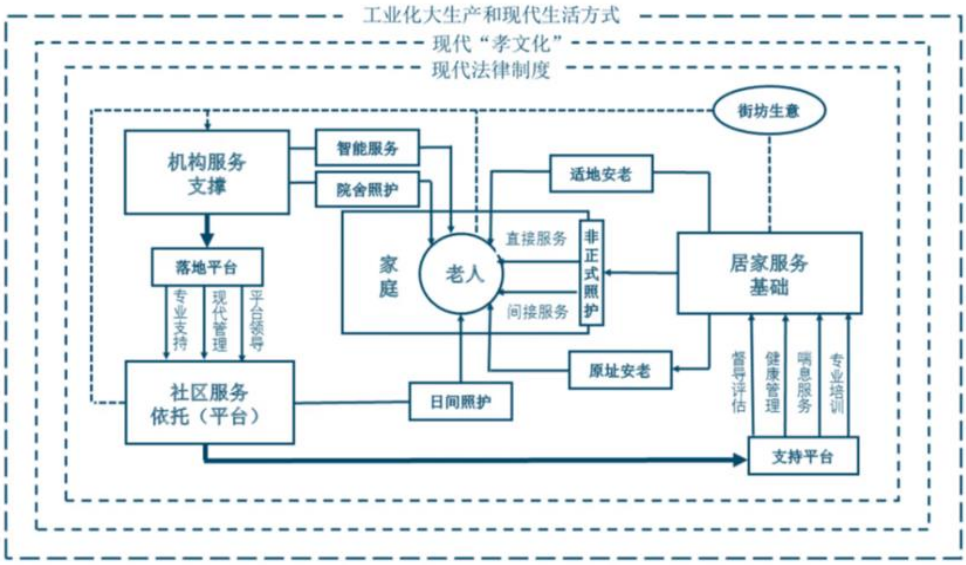
医疗机构护理费收费标准仍然沿用 1999 年制定的《北京市统一医疗服务收费标准》，三级医院的一级护理标准仅为 9 元，二级医院为 6 元，而三级医院的一级护理每日成本已经超过 200 元。医院提供护理服务面临亏损，而社区和小型养老机构主要是与社区卫生服务中心和一级医院合作，但由于合作方医疗设施简陋，基本上很难满足社区和养老机构对高质量医疗服务的需求。

1.2.2. 宏观：“孝文化”的羁绊

传统孝文化与新兴的养老模式之间的冲突，正成为老年护理行业面临的重要痛点。家庭养老模式不仅是农业社会的客观产物，也是儒家文化中“孝悌为仁之本”的理念体现。老年人渴望子女的赡养和关怀，认为去养老院是一种不太幸福的结局。而随着养老理念的多元化，传统的家庭养老模式面临深刻的变革。虽然家庭养老与专业化的护理并不冲突，但在现实中，社会常以二元对立的方式看待“居家养老”和“商业化养老”。

文化伦理带来行业内角色缺位、错位。传统孝文化中，养老被视为子女的义务，子女承担对父母的赡养责任。当老年人进入到养老护理服务体系时，这一“孝”文化的延续性变得模糊不清。护理机构在接受老年人时，往往面临一个伦理和角色定位的难题：究竟是将老年人视为需要无微不至关怀的“家人”，承担某种类似子女的责任？还是将他们视为客户，提供明确的服务和护理？许多护理机构和服务对象在实际操作中并未厘清这一点。一些护理机构试图在情感上扮演“家庭成员”的角色，但这种尝试往往流于表面，难以满足老年人对亲情的渴望。与此同时，部分老年人和家属也没有完全认同护理机构的“服务者”定位，导致对护理期待和实际服务内容之间的落差。在这种错位的观念下，老年人有时会感到缺乏真正的情感关怀；而护理人员则在面对复杂的情感需求时感到力不从心，难以平衡情感照护与专业护理的界限。老年护理行业在文化和伦理层面上面临挑战——既要满足老年人对情感和尊严的需求，又要在商业化的护理服务中保持专业性。

图31：孝文化背景下的老年护理



资料来源：唐钧在中国养老服务业专家沙龙的现场发言

老年护理的特殊性不仅体现在生活照料方面，更体现在心理和情感护理上。老年人渴望被尊重、希望他人的认可与倾听。这种“自我价值需求”是老年护理中不可忽视的重要方面。随着家庭养老、社区养老和社会机构养老模式的并存与转化，老年护理行业正呈现出多元化、社会化的趋势。**如何继承和弘扬传统的道德伦理观念，避免角色错位，明确护理机构应承担的责任，并在情感和专业护理之间找到平衡点，是新时代养老护理行业亟待解决的核心问题。**

1.2.3 中观：养、护、医、送四大功能的分离

产业链逐渐完整，涉及多个环节。包括从上游的设备和产品供应商（如医疗器械、康复设备、健康食品等制造商），到中游的养老护理服务机构（如养老院、护理院、康复中心等），再到下游的养老支付与社会保险等服务。通过政策支持和资金投入推动行业发展的政府、社保基金等主体，也在其中扮演着重要角色。

价值链则关注价值创造、价值传递和价值实现三个阶段。价值创造阶段关注老年人的需求和期望；价值传递阶段主要关注服务的质量和效率，通过优化服务流程和提高服务质量来传递价值；价值实现阶段则关注服务的经济效益和社会效益，通过合理的收费和有效的监管来实现价值。

图32：养老护理的价值链定位

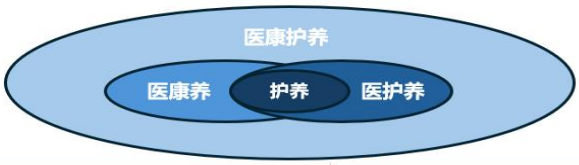


资料来源：公开资料

价值链中四大功能分离抑制协同效应潜力。养老护理行业包括四个主要功能模块：养（养老）、护（护理）、医（医疗）、送（安宁护理和临终关怀），实践中仍然存在着显著的四大功能分离现象，进一步导致了价值链中的各环节往往缺乏有效整合，造成价值创造不足和价值实现困难。养老机构、护理机构、医疗机构分别由不同的组织管理，服务模式和盈利模式各异，各类机构间缺乏沟通和合作的机制。不同机构对服务标准的理解和执行存在差异，尤其是在医疗和护理服务的衔接方面，缺乏统一的服务流程和标准。不仅增加了老年人及其家属的负担，也影响了服务的整体质量。

医养结合逐渐成为我国养老护理行业发展的核心理念。作为功能整合的尝试，“医养结合”这一概念由学者郭东等人在 2005 年首次提出[9]。2015 年，国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》（国办发〔2015〕14 号），以专门篇幅对此提出工作要求。2017 年，党的十九大报告强调推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。已有研究显示，基于不同养老需求和相应供给定位，目前的养老护理行业已催生出多样化的医养结合护理子体系。

图33：多样化的医养结合体系



	护养	医护养
特点	重心在“养”，侧重生活照护、精神关爱服务	重心在满足失能半失能老人的长期照护需求
	着重以预防、养生、保健为主的健康管理	着重提供专业化的医疗护理服务
	浅层次的医养结合	医养结合的程度较高
	常见于以老年公寓为代表的养老机构中	常见于护理院，大多从养老院或医疗卫生机构升级而来
例子	南京“三槐”养老连锁机构、扬州飞鸿老年公寓	苏州的兴卫护理院；徐州的康馨老年护理院

	医康养	医康护养
特点	重心在老年躯体、精神的康复治疗，以短期照护为目标	重心在服务的连续性，全面整合医康护养功能，
	着重运用基础护理和各科专业的护理技术	着重开展涵盖生活照料、医疗、康复、护理等一体化健康照护服务
	医养结合的程度较高	组建医生、护士、心理师、康复师等多学科服务团队
	常见于康复医院	常见于集团性质的养老机构或医院
例子	南京瑞海博康复医院	邳州福利中心、常州369养老产业集团

资料来源：公开资料，从容应队整理

我国医养结合理念下的养老服务体系仍处于初级探索阶段。尽管实践中多样化的老年护理服务子体系丰富了医养结合的内涵[10]，但多为服务内容的简单而非深层次整合，本质上仍未解决“政策碎片化、部门管理化”的问题。且覆盖范围狭窄，限于城镇、养老机构与医疗机构之间，农村地区以及社区居家方面的医养结合服务严重不足，服务“最后一公里”有待开拓。

1.2.4 微观：企业内缺乏护理人才，服务产品矩阵欠缺差异性

人口老龄化发展对养老护理人才需求与要求提高，老年护理行业中的企业出现明显的人才缺口。

1.数量不足：依据国家卫健委 2021 年数据，我国失能失智老年群体约有 4500 万人，持证的养老护理员只有 50 万人。近年来，来自家庭的传统照护力量有所弱化，对护理人员的社会化、市场化供给需求逐渐增长。失能、高龄、空巢老年人的照护需求更为迫切，找不到合适养老护工的难题困扰了很多家庭。人力资源和社会保障部近年发布的“全国招聘大于求职‘最缺工’的 100 个职业排行”中，养老护理员居于前列[13]。

表9：2030-2050 年长期护理需求人数与长期护理人才需求量预估

	65岁及以上人口数（万人）	生活不能自理率（%）	长期护理需求人数（万人）	入住老年养护机构比例（%）	长期护理护士需求（万人）	长期护理护士员需求（万人）	长期护理人才需求（万人）
2030	22945	8.9	2042	13.2	89.9	179.7	269.6
2035	27920	8.9	2485	15.6	129.2	258.4	387.6
2040	31709	8.9	2822	18.1	170.3	340.5	510.8
2045	32319	8.9	2876	20.5	196.6	393.1	589.7
2050	33120	8.9	2948	23	226	452	678

资料来源：65 岁及以上老年人口数据、生活不能自理串来源于来自于国家统计局发布的关于人口的最新数据，并假定 2030~2050 年保持不变:入住养老机构比例；根据《中国民政统计年鉴》有关效据计算:护理人员计算标准:护理人员与失能老年人比例 0.8:1，长期护理护士与护理员之比为 1:2.

2.需求变化导致供需双方匹配难度加大：行业发展面临严重的供需矛盾，供给高——利用低、供给低——需求高、服务需求高——服务利用低等现象突出。老年群体在地域习俗、收入水平、文化程度等方面有所不同，形成显著的需求层次差异。老年护理服务的供给数量、质量与结构趋于同质[9]，质量良莠不齐等导致养老服务供给与实际需求存在错位。照护涉及多个方面，一方面对职业操守有较高要求，需要吃苦耐劳、有耐心，另一方面也需要生活照护、保健康复、心理抚慰等专业技能，对专业性要求并不低。现有的养老护理服务提供者中，既有来自家政行业的保姆、医疗机构的护工，也有专门的“养老护理员”。但总体来看，我国大多数养老护理人才素质未达标，缺乏沟通技巧、临终关怀知识等，持证上岗比例较低[14]。

服务产品矩阵也存在类似的问题。

1.同质化现象尤为明显，老年人群需求的多样性与服务产品单一性的矛盾。服务基本聚焦在帮助老年人进行日常生活活动（ADL，如穿衣、进食、洗澡等）以及提供简单的医疗护理（如血压测量、药物管理等），缺乏针对不同老年人群的差异化服务设计。而老年人的需求呈现出高度的多样性。当前的老年护理服务产品往往将老年人群体视为一个整体，忽视了其中的内部差异性，潜在的导致很多服务资源的浪费。如，身体机能较弱的老年人需要医疗护理和日常照料服务，但身体健康状况较好的老年人可能更需要社会活动和心理支持。

2.服务设计缺乏精细化分层，产品和服务研发理念滞后。许多服务提供商为了简化流程、降低成本，将服务内容进行高度标准化，导致服务产品矩阵中缺乏精细化分层和具体的差异化设计。如许多护理机构提供的服务套餐往往是统一定价和服务内容，不根据老年人的具体情况进行调整。另一方面，尽管一些高端护理机构开始提供定制化的服务，但由于成本高昂，普通老年人难以负担。目前多

数护理产品和服务的内核都是“减少和替代老年人自身的活动”，却忽视了老年人自助式产业的发展。

2.宏观实证

基于CHARLS数据库的老年护理供需多维透视



2. 宏观实证——基于 CHARLS 数据的老年护理供需关系多维透视

2.1. 研究目的与变量选取

老年群体照护服务主要分为家庭照护（90%），社区照护（7%），机构照护（3%）。家庭照护的供给主体为老年人的子女。在当前老龄化、少子化趋势加强的宏观背景下，家庭供给愈发乏力，老年群体的照护（护理）需求出现越来越大的缺口。了解老年护理的供需关系对于制定合理的养老政策、提供优质的老年护理服务至关重要。

本研究基于中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据库中 2013 年、2015 年、2018 年和 2020 年的数据，通过固定效应回归模型和相对重要性分析方法洞察影响老年群体与子女互动（见面及联系）的相关因素及影响机制，为养老护理行业的发展方向提供理论依据。

表10：解释变量与被解释变量

被解释变量	老年护理家庭供给数量	联系频率	ConFreq	受访者过去一年和子女的联系频率
		见面频率	SeeFreq	受访者过去一年和子女的见面频率
解释变量	个人特征变量	性别	Gender	受访者的性别
		年龄	Age	受访者受访时的年龄
		受教育程度	Edu	不包括成人教育，受访者的受教育年数
		失能程度	Disability	根据ADL指标计分，受访者健康/失能
	家庭结构变量	是否有同居伴侣	Partner	受访者是否有同居伴侣
		子女平均受教育程度	ChildEdu	不包括成人教育，受访者子女的平均受教育年数
	地区时间变量	城乡属性	Urban	受访者居住于城市/乡村
		年份	Year	受访年份

资料来源：CHARLS

被解释变量为受访老年人与子女的联系频率（ConFreq）和见面频率（SeeFreq），记录过去一年内老年人与其所有子女的联系和见面频率均值，数值从 0 至 10，数值越大表示频率越高、互动越频繁。老年人和子女的联系和见面频率是衡量亲子紧密程度的重要指标，体现家庭对老年人护理需求的供给机会。

根据个人特征、家庭结构和地区时间，选择解释变量：性别、年龄、受教育

程度、失能程度、是否有同居伴侣、子女平均受教育程度、居住地城乡属性、年份。其中，性别（Gender）赋值为 1 代表男性，赋值为 2 代表女性。受教育程度（Edu）和子女平均受教育程度（ChildEdu）为连续变量，以受教育的年数计。伴侣（Partner）赋值为 1 代表有同居伴侣，赋值为 0 代表无同居伴侣。城乡属性（Urban）赋值为 1 代表城市，0 代表乡村。

对于失能程度（Disability）的评估，本文采取 Sidney Katz 于 1963 年提出的 ADL（Activities of Daily Living）指标，测量老年人日常生活的自理能力。ADL 量表的主要内容包含进食、洗澡、穿衣、室内行动、上下床、上厕所 6 项。对应 CHARLS 数据库中对于该 6 项分别提供的选项“没有困难”、“有困难但可以完成”、“有困难且需要帮助”、“无法完成”，本文参考《全国城乡失能老年人状况研究》（2011，中国老龄科学研究中心课题组）的判定方法，如果都回答“没有困难”或“有困难但可以完成”，就判定为完全自理；只要有一项回答“有困难且需要帮助”，就判定为部分自理；只要有一项回答“无法完成”，则判定为不能自理。本研究将完全自理的老年人归类为健康组，部分自理和不能自理的老年人归类为失能组。

2.2. 描述性分析

本研究涉及的主要变量包括子女与受访老年人每月平均联系频率和见面频率、受访者年龄、性别、有无同居伴侣、受访者教育水平、子女平均教育水平、失能程度、居住地点的城乡属性。

表11：描述性统计

Descriptive Statistics

VARIABLES	(1) N	(2) mean	(3) Sd	(4) min	(5) max
Gender	78,874	1.527	0.499	1	2
Partner	78,911	0.826	0.379	0	1
SeeFreq	47,159	5.734	2.198	1	10
ConFreq	45,959	6.855	2.303	1	10
Disability	78,532	1.084	0.351	1	3
Age	68,999	58.82	10.13	11	108
Year	78,911	2,017	2.658	2,013	2,020
Edu	42,044	6.002	4.090	0	22
ChildEdu	26,363	10.24	4.302	0	22
Urban	78,911	0.404	0.491	0	1

2.3. 基准回归分析

2.3.1. 模型概述

本研究采用固定效应模型，引入城市固定效应以控制不随年份变化的城市特性，引入年份固定效应以控制不随个体变化的逐年时间趋势。进一步地，本研究在城市和年份层面实施了聚类分析，考虑对应组内的相关性及组间的异方差，从而得到一致性的估计量。

模型建构如下：

$$ConFreq_{ict} = \beta_0 + \beta_1 Age_{ict} + \beta_2 Partner_{ict} + \beta_3 Gender_{ict} + \beta_4 Urban_{ict} + \beta_5 Edu_{ict} + \beta_6 ChildEdu_{ict} + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{ict}$$

$$SeeFreq_{ict} = \beta_0 + \beta_1 Age_{ict} + \beta_2 Partner_{ict} + \beta_3 Gender_{ict} + \beta_4 Urban_{ict} + \beta_5 Edu_{ict} + \beta_6 ChildEdu_{ict} + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{ict}$$

其中，$ConFreq_{ict}$ 和 $SeeFreq_{ict}$ 分别代表老年个体 i 在城市 c 年份 t 间与子女的联系频率和见面频率。同时，解释变量包括个体年龄 Age、有无配偶 Partner、性别 Gender、居住地是否为城市 Urban，以及老年人个体的受教育程度 Edu 和其子女的平均受教育水平 ChildEdu。γ_c 代表城市固定效应，λ_t 代表年份固定效应，ε_{ict} 表示扰动项。另外，考虑到扰动项间的自相关及异方差问题，本研究在城市和年份层面对标准误进行聚类，从而提高估计的准确性。

2.3.2. 回归结果

表12：全样本回归结果

变量	ConFreq			SeeFreq		
Age	-0.0602***	-0.0592***	-0.0592***	0.0264***	0.0264***	0.0264**
	(0.0024)	(0.0028)	(0.0028)	(0.0022)	(0.0029)	(0.0045)
Partner	0.4841***	0.5066***	0.5066**	0.2255***	0.2255***	0.2255*
	(0.0543)	(0.0570)	(0.600)	(0.0489)	(0.0621)	(0.0461)
Edu	0.0588***	0.0588***	0.0588***	0.150*	0.0150*	0.0150*
	(0.0070)	(0.0070)	(0.0047)	(0.0062)	(0.0061)	(0.0037)
ChildEdu	0.0727***	0.0727***	0.0727**	-0.0114*	-0.0114	-0.0114
	(0.0062)	(0.0064)	(0.0078)	(0.0056)	(0.0066)	(0.0114)
Gender	0.0979*	0.0980*	0.0979	0.1829***	0.1829***	0.1829
	(0.0494)	(0.0473)	(0.0411)	(0.0439)	(0.0481)	0.0774
Urban	-0.0304	-0.0304	-0.0304	0.6566***	0.6566***	0.6566*
	(0.0641)	(0.0850)	(0.0869)	(0.0560)	(0.1078)	(0.1259)

城市固定	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份固定	Y	Y	Y	Y	Y	Y
城市聚类	N	Y	Y	N	Y	Y
年份聚类	N	N	Y	N	N	Y
观测值	8945	8945	8945	10620	10620	10620

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%水平上的统计显著性；( )内为对应标准误

回归结果如表 12 所示，展示了各个解释变量对老年人与子女互动频率的影响。（列（1）至列（3）为联系频率，列（4）至列（6）为见面频率。）列（1）和（4）控制了城市和年份的双向固定效应。列（2）和（5）在城市层面进行聚类。列（3）和（6）在城市和年份层面进行二维聚类。本研究发现，回归结果在各个条件下维持较好的稳健性。以下就各解释变量进行详细分析：

年龄（Age）：随着年龄增长，老年人与子女的联系频率逐渐降低，而见面频率呈现上升态势。推测其原因可能与智能通信设备使用困难度以及孝文化观念有关。一方面，年龄增长可能导致老年人在使用智能通信设备时面临困难，从而使得他们更依赖于见面这种传统的交流方式；另一方面，孝文化观念可能促使子女在父母年老时更倾向于面对面的交流与陪伴。

伴侣（Partner）：同居伴侣的存在对联系频率和见面频率均有着显著的正向影响。伴侣的陪伴不仅为老年人提供了情感上的支持，也可能在一定程度上促进老年人与子女的互动。例如，伴侣可以提醒、推动老年人与子女保持联系。

受教育程度（Edu）：受教育水平较高的老年人与子女的联系频率和见面频率均更高，或与高知识水平所带来的正外部性相关。高教育水平的老年人可能更注重家庭关系的维护，积极主动地与子女保持联系。

子女受教育程度（ChildEdu）：子女受教育程度对联系频率有显著的正向影响，但对见面频率无显著影响。受教育程度较高的子女可能更善于利用现代通信工具与父母保持联系，但由于工作和生活的压力，可能较少有时间与父母见面。

性别（Gender）：相比老年男性，老年女性与子女的联系和见面频率更高。这可能与社会文化因素以及女性的性格特点有关。在传统社会中，女性通常被赋予更多的家庭责任，更注重家庭关系的维护。此外，女性可能更善于表达情感，更容易与子女建立亲密的关系。

城乡属性（Urban）：居住地的城乡属性对联系频率无显著影响，但对于见面频率影响较强。城市老年人与子女的见面频率远高于农村老年人。城市地区通

常拥有更便捷的交通、更丰富的社交活动和更好的医疗服务，、可能使得老年人与子女见面机会更多。而农村地区可能由于交通不便、社交资源匮乏等原因，导致老年人与子女见面的频率相对较低

2.3.3. 相对重要性分析

本文在基准回归的基础上采用优势分析(Dominance Analysis)，比较解释变量对被解释变量变异程度的相对重要性。通过对比不同的解释变量对模型拟合度的独立贡献程度，衡量变量的相对重要性。为便于分析，对相对重要性指标进行标准化，使模型各解释变量标准化之后的相对重要性指标之和等于 1。

表13：相对重要性分析

ConFreq 相对重要性分析					
变量	全样本	健康	失能	居住于城市	居住于乡村
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
Age	0.5314[1]	0.5302[1]	0.4914[1]	0.4065[1]	0.6145[1]
Partner	0.1391[4]	0.1274[4]	0.3689[2]	0.1459[4]	0.1376[2]
Edu	0.1641[2]	0.1647[2]	0.0869[3]	0.2325[2]	0.1234[3]
ChildEdu	0.1496[3]	0.1625[3]	0.0286[4]	0.2053[3]	0.1175[4]
Gender	0.0069[6]	0.0066[6]	0.0129[5]	0.0097[5]	0.0070[5]
Urban	0.0087[5]	0.0086[5]	0.0113[6]	\	\
SeeFreq 相对重要性分析					
变量	全样本	健康	失能	居住于城市	居住于乡村
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
Age	0.1902[2]	0.1936[2]	0.0860[3]	0.7007[1]	0.3781[1]
Partner	0.0271[5]	0.0315[5]	0.0121[6]	0.0989[3]	0.0758[5]
Edu	0.0689[3]	0.0723[3]	0.0374[5]	0.0526[4]	0.1467[3]
ChildEdu	0.0237[6]	0.0220[6]	0.0653[4]	0.0401[5]	0.2831[2]
Gender	0.0460[4]	0.0442[4]	0.0920[2]	0.1078[2]	0.1163[4]
urban_nbs	0.6440[1]	0.6364[1]	0.7072[1]	\	\

注：[ ]中为各变量的相对重要性排名

表 13 列（1）为全样本回归中各解释变量对模型拟合度的贡献度，中括号中的数字为解释变量中各变量相对重要性的排序。对于联系频率，无论分组情况如何，年龄始终为最重要的影响因素，且年龄与联系频率呈负相关。老年人自身和子女的教育水平分别位居第 2 名、第 3 名，可见教育程度对维系亲子联系也具有较高的影响。对于见面频率，无论分组情况如何，城乡属性始终为最重要的影响因素，城市老年人具有压倒性的优势，与子女见面更频繁。

列（2）和列（3）按老年人的失能程度分组。对于联系频率，同居伴侣对健康老年人的相对重要性在 6 个变量中排名第 4，而对失能老年人的相对重要性仅次于年龄，排名第 2。这表面失能老年人的同居伴侣对其与子女维持联系具有较强的影响。

列（4）和列（5）按老年人的居住地城乡属性分组。对于联系频率，与失能程度分组情况相似，相比城市老年人的同居伴侣，农村老年人的同居伴侣对其与子女维持联系具有较强的影响。对于见面频率，性别对农村老年人的相对重要性排名第 4，而对城市老年人的相对重要性排名第 2。相比城市男性老年人，城市女性老年人与子女见面频率更高。

2.4. 失能程度异质性分析

根据 ADL 指标得出的失能群体为老年护理市场核心需求群体。本研究构建了 Disability 的二维变量（0 代表健康，1 代表失能），并在模型中引入 Disability 及 Disability 与各控制变量的交互项，以此分析各解释变量在不同健康水平下对老年人与子女互动频率的影响。对健康组和失能组进行异质性分析，结果如下。

表14：失能程度异质性分析

变量		ConFreq		SeeFreq	
Disability × Age	健康	-0.0592 ***	-0.0592***	0.0266***	0.0266***
		(0.0025)	(00030)	(0.0023)	(0.0030)
	失能	-0.0430 ***	-0.0430***	0.0228**	0.0228**
		(0.0097)	(0.0119)	(0.0089)	(0.0087)
Disability × Partner	健康	0.4840 ***	0.4840***	0.2370***	0.2370***
		(0.0560)	(0.0584)	(0.0505)	(0.0657)
	失能	0.7949***	0.7949**	0.0774	0.0774
		(0.2245)	(0.2551)	(0.2018)	(0.1864)
Disability × Edu	健康	0.0583***	0.0583***	0.0150*	0.0150*
		(0.0072)	(0.0075)	(0.0064)	(0.0062)
	失能	0.315	0.315	0.0184	0.0184
		(0.0270)	(0.0270)	(0.260)	(0.0214)
Disability × ChildEdu	健康	0.0747***	0.747***	-0.0108	-0.0108
		(0.0064)	(0.0068)	(0.0058)	(0.0067)
	失能	0.0331	0.0331	-0.0230	-0.0230
		(0.0208)	(0.0261)	(0.0194)	(0.0186)
Disability × Gender	健康	0.0918	0.0918	0.1843***	0.1843***
		(0.0506)	(0.0495)	(0.0450)	(0.0483)
	失能	0.1660	0.1660	0.1785	0.1785
		(0.2285)	(0.2352)	(0.2053)	(0.2081)
Disability × Urban	健康	-0.0452	-0.0452	0.6529***	0.6529***

	失能	(0.0651)	(0.0854)	(0.0568)	(0.1086)
		0.0747	0.0964	0.7472***	0.7472**
		(0.2303)	(0.2618)	(0.2035)	(0.2111)
城市固定		Y	Y	Y	Y
年份固定		Y	Y	Y	Y
失能程度固定		Y	Y	Y	Y
城市聚类		N	Y	N	Y
观测值		8925	8925	10596	10596

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%水平上的统计显著性；( )内为聚类稳健标准误

同居伴侣对失能老年人与子女联系频率的正效应比健康组更高，结合相对重要性分析的异质性分析结果，可见失能老年人的同居伴侣对其与子女维持联系确实具有较强的影响。有伴侣的失能老年人与子女联系更频繁，猜测或系失能老年人的同居伴侣照顾和心理压力等因素所致。

在健康组，老年人自身和子女的受教育程度对联系频率和见面频率均有显著的正效应，且结合相对重要性分析结果，两代的受教育程度对于联系频率的相对重要性仅次于年龄变量。然而，在失能组，老年人自身和子女的受教育程度对联系频率和见面频率的促进效应消失了。当老年人失能后，教育程度的积极影响似乎被其他更为紧迫的因素所掩盖，如照顾负担、经济压力等。该现象一定程度上暗示了 “久病床前无孝子” 的难题可能存在。此外，相比健康老年男性，健康老年女性与子女见面更频繁；而在失能组，性别没有显著影响。

2.5. 城乡属性异质性分析

与上文对应地，本研究在模型中引入城乡属性 Urban（0 代表乡村，1 代表城市）及 Urban 与各控制变量的交互项，以此分析各解释变量在不同城乡属性下对老年人与子女互动频率的影响。结合全样本回归模型和相对重要性分析结果，城乡属性对老年人与子女的见面频率有较强的影响。考虑城乡在经济水平、服务供给、基础建设等方面存在显著差异，对老年人与子女的互动影响较大，为进一步探究，展开异质性分析，结果如下。

表15：城乡属性异质性分析

变量		ConFreq		SeeFreq	
Urban × Age	城市	-0.0530***	-0.0530***	0.0335***	0.0335***
		(0.0041)	(0.0047)	(0.0036)	(0.0046)
	乡村	-0.0629***	-0.0629***	0.0220***	0.0220***
		(0.0030)	(0.0036)	(0.0028)	(0.0032)
Urban × Partner	城市	0.5741***	0.5741***	0.4090***	0.4090***

		(0.0984)	(0.1111)	(0.0834)	(0.1111)
	乡村	0.4785***	0.4785***	0.1326*	0.1326
		(0.6485)	(0.0685)	(0.0601)	(0.0712)
	城市	0.0777***	0.0777***	0.0165	0.0165
Urban × Edu		(0.0121)	(0.0152)	(0.0101)	(0.0112)
	乡村	0.0478***	0.0478***	0.0128	0.0128
		(0.0085)	(0.0082)	(0.0078)	(0.0079)
	城市	0.0936***	0.0936***	-0.0042	-0.0042
Urban × ChildEdu		(0.0101)	(0.0108)	(0.0087)	(0.0108)
	乡村	0.0624***	0.0624***	0.0160*	-0.0160*
		(0.0071)	(0.0069)	(0.0065)	(0.0070)
	城市	0.2088*	0.2088*	0.2972***	0.2972***
Urban × Gender		(0.0873)	(0.0935)	(0.0729)	(0.0881)
	乡村	0.0396	0.0396	0.1326*	0.1207*
		(0.0597)	(0.0563)	(0.0548)	(0.0570)
城市固定		Y	Y	Y	Y
年份固定		Y	Y	Y	Y
城乡固定		Y	Y	Y	Y
城市聚类		N	Y	N	Y
观测值		8945	8945	10596	10596

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%水平上的统计显著性；( )内为聚类稳健标准误

由结果可知，城乡差异显著。对比城市老年人，乡村地区的老年人与子女的互动呈现出更强的下降趋势和更弱的改善效应。对于联系频率，年龄对城市和乡村地区的老年人均产生负效应，而乡村组的年龄系数-0.0629 大于城市组的年龄系数-0.0530。在全样本回归模型（聚类城市）中，年龄系数为-0.0592。这表面随着年龄增长，乡村老年人与子女的联系频率呈现出更强的下降趋势。

而乡村组同居伴侣、受教育水平、子女平均受教育水平变量在联系频率回归模型中的系数均低于城市组，这意味着伴侣和教育对于乡村老年人与子女的联系的改善效应比城市组弱。同时，对于见面频率，年龄对城市和乡村地区的老年人均为正效应，但乡村组的年龄系数 0.0220 小于城市组的年龄系数 0.0335；在全样本回归模型（聚类城市）中，年龄系数为-0.0592。即随着年龄增长，乡村老年人与子女见面次数的增加趋势更弱。

2.6. 实证研究总结与政策建议

本研究基于中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据库的数据，采用固定效应回归模型和相对重要性分析方法，对老年群体与子女互动的影响因素及影响机制进行了深入分析。研究结果如下：

1.随着年龄的增长，老年人与子女的联系频率逐渐降低，而见面频率呈现上升态势。这可能与老年人使用智能通信设备的困难度以及孝文化观念的影响有关。

2.同居伴侣的存在对老年人与子女的联系频率和见面频率均有着显著的正向影响，特别是失能老年人的同居伴侣对其与子女维持联系具有较强的影响。目前老年群体对于伴侣的依赖性较高，暗示子女方的照护供给相对乏力，而机构和社区并没有充分弥补这种缺失。

3.虽然受教育水平较高的老年人与子女的联系频率和见面频率均更高，而子女受教育程度对联系频率有显著的正向影响，但是而教育程度的积极影响在失能老年人中消失，即无论受教育程度高低陷入失能或半失能状态的老人从子女处获得的家庭照护均呈下降趋势。

4.相比老年男性，老年女性与子女的联系和见面频率更高，可能与社会文化因素以及女性的性格特点有关。

5.居住地的城乡属性对见面频率影响较强，城市老年人与子女的见面频率远高于农村老年人。乡村老年人与子女的互动呈现出更强的下降趋势和更弱的改善效应。农村老年人在经济地位上处于劣势地位，且家庭照护供给数量更少，需要格外关注。

根据实证分析结果，在老龄化和少子化的趋势下，占 90%的家庭照护越来越难以满足老年群体的照护需求，而机构养老和社区养老尚未形成成熟且高效的补位机制。政府力量和市场企业两大主体有必要深入到老年照护的实践中，解决现有的行业痛点。

深究本研究结果背后的原因，本研究认为政府和市场力量在优化老年护理供给可以从以下三个层面方面可以进一步加强：

1.家庭层面：（1）增强子女养老意识与能力：开展孝道教育活动，强化子女对赡养老人责任与义务的认知，提高其主动关心和照顾老年父母的意识。针对子女举办护理技能培训课程，如失能老人日常护理方法、紧急情况应对等，提升子女照顾老人的实际能力，使其能更好地应对老年父母可能出现的各种健康问题，从而增强家庭照护的质量和效果。（2）改善老年人家庭沟通环境：鼓励家庭成员之间定期开展家庭聚会、共同参与休闲活动等，增进彼此感情，营造温馨和谐的家庭氛围，为老年人提供丰富的情感支持，减少其孤独感和心理压力，有助于

提升老年人的生活满意度和身心健康水平。倡导家庭成员制定定期沟通计划，如每周固定时间进行电话或视频通话，每月安排家庭团聚等，确保老年人与子女之间保持密切的联系，及时了解彼此的生活状况和需求，及时解决可能出现的问题，强化家庭纽带。

2.社会层面：（1）加强伴侣支持体系建设：针对老年人的同居伴侣，尤其是失能老人的伴侣，组织专业护理培训课程，内容涵盖日常生活照料技能、康复护理知识、心理关怀技巧等，帮助伴侣更好地照顾老人，减轻其照顾负担，同时增强其在促进老人与子女互动中的积极作用。（2）设立心理辅导与咨询服务：为老年人伴侣提供心理辅导和咨询渠道，帮助他们应对长期照顾老人过程中产生的心理压力、焦虑情绪等，增强其心理调适能力，确保其自身心理健康，从而能更积极地支持老年人与子女的互动，维护家庭关系稳定。（3）丰富老年教育资源与课程：在社区、老年活动中心等地开设多样化的课程，如文化艺术、健康养生、信息技术应用等，满足不同老年人的学习需求，提升其知识水平和综合素质，不仅有助于老年人自身发展，也能增强其与子女交流的话题和互动的意愿。（4）鼓励老年人参与社会活动：组织各类适合老年人参与的社会活动，如志愿者服务、兴趣小组活动、文化交流活动等，促进老年人融入社会，拓展社交圈子，减少对子女的过度依赖，同时也能让子女看到老年人积极的生活态度和丰富的生活内容，增进彼此之间的理解和尊重。

3. 城乡统筹层面：（1）加大农村养老设施建设投入：政府在财政预算中增加对农村地区养老服务设施建设的专项资金，用于改善农村养老院、日间照料中心、医疗服务站等基础设施条件，确保农村老年人能够享受到与城市相当的基本养老服务，缩小城乡养老服务差距。（2）加强农村养老服务人才培养：通过定向培养、培训补贴、提高待遇等方式，吸引和留住专业养老服务人才在农村地区工作，提升农村养老服务的专业化水平，为农村老年人提供高质量的护理、康复、心理疏导等服务，改善农村老年人的生活质量，增强农村家庭养老的信心和能力。（3）促进城乡养老服务协同发展：城市优质养老服务机构与农村养老服务设施开展合作，通过技术支持、人员培训、服务共享等方式，将城市先进的养老服务理念、管理经验和服务模式引入农村，提升农村养老服务水平，实现城乡养老服务协同发展。（4）推动城乡养老服务一体化政策制定：政府部门在制定养老服

务政策时，充分考虑城乡差异，统筹规划城乡养老服务体系建设，确保政策的公平性和可操作性，促进城乡养老服务要素合理流动，逐步实现城乡养老服务一体化发展，为全体老年人提供均等化的养老服务保障.通过这些政策建议，可以有效地改善老年群体的照护服务，提高老年人的生活质量，并促进家庭关系的和谐。



3.微观案例

头部企业异质性破局的机制分析



3. 微观案例——头部企业异质性破局的机制分析

3.1. 战略布局：上市公司年度报告词云图（基于 python）

本研究通过 Python 技术，对行业内头部上市公司年报进行了深入的词频分析，以了解业务焦点和行业趋势。图中最显眼的词汇是**“医养结合”和“个性化护理”**，表明公司正在将医疗服务与养老服务相结合，满足老年人对健康和日常生活照料的双重需求。同时，公司也在强调为每位老年人提供定制化的护理服务，以适应他们的个人健康状况和偏好。**“大数据”和“健康管理”**的出现，显示了公司在利用现代技术来提升服务质量和效率方面的努力。通过收集和分析老年人的健康数据，公司能够提供更加精准的护理和预防措施。此外，**“智能护理设备”和“APP”**的提及，表明公司正在采用科技手段，如远程监控和移动应用程序，来增强护理服务的便捷性和可及性。**“行业规范”和“护理标准”**的词汇，反映了公司对提升服务质量和安全性的承诺，以及对行业标准化的追求。这些公司可能在积极参与制定或遵循行业标准，以确保提供高标准的护理服务。**“居家养老”和“社区日间照料”**的词汇，揭示了公司在支持老年人在家中或社区环境中获得必要护理的业务模式。这种模式有助于老年人保持独立性和社会联系，同时也减轻了家庭护理者的负担。**“康复器械”和“康复训练”**的提及，表明公司在帮助老年人恢复身体功能和提高生活质量方面的投入。这些服务可能包括物理治疗、职业治疗等，旨在帮助老年人恢复或维持日常生活能力。总体来看，这张词云图展示了老年护理行业在追求服务质量、技术创新、个性化服务和行业标准化方面的发展趋势。头部上市公司通过提供医养结合的护理模式、利用大数据和智能设备、以及支持居家和社区养老，来满足老年人的多样化需求，并推动行业的可持续发展。

图34：养老健康领域年报词云



资料来源：悦心健康 2020-2024 年报半年报老年护理业务部分

老年护理行业的竞争格局也日益激烈。

首先，医养结合成为了行业的一个重要趋势。公司如**泰康之家、亲和源**等，通过提供综合性的养老服务，为公司在市场中赢得了竞争优势。其次，个性化护理服务也是行业竞争的一个焦点。随着老年人需求的多样化，公司开始提供定制化的服务，如康复训练、营养师咨询、助浴服务等，以满足不同老年人的特定需求。这种服务的个性化不仅提升了客户满意度，也增强了公司的市场竞争力。此外，科技的应用也在改变老年护理行业的服务模式。

在区域竞争格局方面，**华东地区**由于经济发达和人口老龄化程度较高，成为了养老产业区域集中度最高的地区，占比约 34%。华南和西南地区也表现出较高的集中度。这种区域集中的趋势反映了老年护理服务需求与经济发展水平和人口结构的紧密联系。

总体来看，老年护理行业的竞争格局呈现出多元化和差异化的特点。**大型养老护理机构通过规模优势和品牌影响力占据了一定的市场份额，而小型养老护理机构则凭借其灵活性和专业性在特定领域和细分市场中获得一席之地。**预计未来几年，养老护理行业将继续保持稳定增长态势。

3.2. 案例聚焦

3.2.1. 头部企业横向对比

1.亲和源：孝文化的服务营销实践

亲和源定位于行业标准制定者，致力于成为中国商业养老的“示范田”。其业务特点在于将中国传统文化中的“孝”文化融入到养老服务中，通过提供全面

的生活照料、健康医疗、文化娱乐等“秘书式”管家服务，以及专业的全护理服务，旨在为老年人打造一个温馨、和谐的养老社区环境。此外，亲和源还采取了外包的方式，广泛整合物业、餐饮、健身、医疗服务等专业服务资源，以吸引更多相对年轻的老年人选择社区养老生活模式盈利模式主要是会员制，包括“年费+会费”和“剃须刀+刀片”的模式，通过收取会员费保证稳定的收入来源，同时通过提供额外的增值服务增加收入。

2.万科：护理人才+产品矩阵的多样性

万科在养老领域的定位是中高端养老服务提供商，主要在一线和新一线城市布局。万科的业务特点体现在其 V-Care 智慧照护平台系统上，该系统规范了护理员的 64 项护理动作，覆盖了多个服务细项，确保了服务的标准化和高质量。万科通过社区嵌入中心、城市全托中心、持续照顾社区等产品类型，适配不同的养老需求，提高服务专业度和精细度，逐步提升养老年人群的入住率。其盈利模式主要是“押金+月费”，入住万科养老社区的老年人需要支付一定数额的押金，以及每月的服务费用，这种模式不仅为万科提供了稳定的现金流，也确保了服务的持续性和高质量。

3.泰康之家：四大功能的整合

泰康之家的定位是高端养老服务提供商，主要在一二线城市的重点区域布局。泰康之家通过提供一站式的养老服务，包括医疗、康复、娱乐和生活照料，为老年人打造了一个全方位的养老生活平台。其业务特点在于其医养产业链闭环一站式健康服务，不仅提供基本的生活照料服务，还整合了医疗、康复、健康管理等资源，为老年人提供全方位的健康服务。泰康之家的盈利模式是“保单捆绑+押金”，将其养老服务与保险产品捆绑销售，通过保险产品的长期收益来平衡养老服务的投入，同时通过收取押金确保服务的稳定提供。

3.2.2. SWOT 分析

1.优势（Strengths）

一体化人才培养体系成熟。在这一点上做的比较好的企业有悦心健康，它通过系统的职业教育和实训，确保了护理人员的专业素养和技能水平。公开数据显示，悦心健康的员工流失率约为 10%，长期保持在行业平均水平以下，2023 年公司康养事业部共开展养老相关业务培训近 60 场，培训人数近 1200 余人次。此

外，公司在运营的养老机构内设有先进的实训中心，模拟真实工作场景，使护理人员能够在实践中学习和提升。

智能化养老服务持续投入，探索面向未来场景。头部企业大多利用智能终端设备和大数据分析技术，为老年人提供个性化的健康管理和护理方案。智能化平台的使用有望使护理人员的工作效率提高约 25%，并降低 15%的管理成本。通过自动化流程，可以在数据整理、排班管理等方面实现高效运作，进一步降低了运营成本。

多元化服务体系打造良好品牌形象。从健康管理、医疗护理到康复护理、养老照护的一体化服务，头部企业整合医疗资源和养老服务，为老年人提供全面、系统的照护，满足了老年人在不同生命周期的需求。

2.劣势（Weaknesses）

资本密集型行业特性影响盈利，成本高居不下。养老服务行业属于资本密集型行业，特别是在养老机构的建设、设备更新和护理人员培训方面需要大量的资金投入[15]。公司财报显示，虽然近年来营业收入持续增长，但资金压力仍较大，尤其是在新项目的开发和运营上。随着市场不确定性增加，企业在融资过程中可能面临更大的挑战。尽管公司在行业内具备一定的品牌优势，但资本市场对养老行业的投资谨慎，尤其是在宏观经济压力时期，融资渠道可能会变得更加紧缩。

人力资源供少求多，缺口大。护理人员的培养周期较长、工作强度高，人员极易流失。随着人口老龄化加剧，市场对专业护理人才的需求显著增加。未来几年中，护理人员供不应求的局面仍可能严重影响公司的发展速度和服务质量。

区域性经营为主，规模化扩张困难。福寿康创始人张军曾表示，“越是专业化的服务往往越难实现规模化的扩张”。目前国内的护理企业中，围绕线下实体站点且拥有自有专业团队的，大都集中在所属区域经营，未能实现规模化的复制。如何建立标准化专业化的管理体系和服务模式，并在全国范围内复制推广，是困扰多数护理企业的一大难题。头部企业的养老护理业务主要集中在北京、上海等一线城市，业务占比超过 70%。过于集中的布局可能导致公司在全国范围内的业务拓展和市场占有率受到限制。未来跨地域扩展过程中，可能面临资源配置不均和市场响应不及时的问题。尤其是在二三线城市的消费力有限，养老服务的定价和服务模式如何调整是公司需要解决的关键问题。

3.机会（Opportunities）

人口老龄化趋势带来稳定的市场需求和新业务拓展空间。随着中国人口老龄化进程的加快，老年人对养老护理服务的需求将持续增长。同时意味着，公司可以针对老年人对健康管理、康复护理等方面的需求，根据不同地区的老年人口特征，开发针对性的服务项目。

政府加大养老产业资金支持，宏观政策向好。我国政府积极应对人口老龄化，出台了一系列土地供给、税收优惠和人才引进方面的政策支持养老服务产业。这些政策为企业提供了有力的政策保障。借助这些政策红利，公司可以进一步扩大业务规模。

科技创新不断发展，打造“养老+”新业态。随着人工智能、大数据、物联网等新技术的广泛应用，企业有机会通过远程医疗、健康监测设备等创新技术，进一步优化服务流程。

4.威胁（Threats）

市场竞争激烈，多方入局分一杯羹。近年来，不少企业乃至资本和巨头都关注到居家护理市场的潜力，相继入局。不仅包括传统的养老机构、新兴的养老服务公司、医疗机构、保险公司，拥有顶级人力、物力、财力资源的互联网大厂如阿里、腾讯也已躬身入局。其中，这些企业可以主要分为三类：以阿里健康、京东健康为首的巨头企业，以福寿康、小柏家护、金牌护士为代表的居家护理专业机构（平台）和以越秀银幸、龙振养老为代表的综合养老服务机构。企业在不断提升自身的服务质量和品牌影响力的同时，要密切关注竞争对手的动作，以保持在市场中的竞争优势。

表16：主要竞争对手分析

机构类别	公司名称	成立时间	公司定位	融资情况	经营状态
互联网巨头	阿里健康	1998年	医药服务和智慧医疗服务平台		在营
	京东健康	2010年	医药销售及医疗健康服务平台		在营
居家照护专业机构/平台	福寿康	2011年	居家康复护理连锁机构	B+轮	在营
	小橙长护	2018年	数字化家庭养老服务提供商	天使轮	在营
	中科护联	2019年	一站式居家护理服务商		在营
	全照护	2018年	老年居家护理服务提供商		在营
	泓华医疗	2013年	综合性医疗服务平台		在营
	小柏家护	2015年	养老护理020服务平台	战略投资	在营
	金牌护士	2015年	护士上门护理服务平台	A+轮	在营
	医护到家	2015年	医生护士上门服务平台	战略投资	在营
	E家康护	2015年	居家康复护理服务提供商		在营
	佳佳康复	2015年	老年居家康复护理平台	天使轮	注销
	医家通	2011年	智慧养老服务平台		在营
	守护云	2015年	智慧居家养老服务平台	天使轮	在营
	青松康护	2004年	康护护理服务机构	B轮	在营
	瑞泉护理	2013年	康复护理服务提供商	B轮	在营
综合养老服务机构	越秀银幸	2015年	现代养老服务提供商		在营
	龙振养老	2014年	养老连锁服务机构		在营
	普亲养老	2008年	失能失智养老服务商		在营
	侨亚集团	2009年	综合性养老服务平台		在营
	擎海信息	2012年	智能养老服务平台		在营

资料来源：公开资料

政策变化增加不确定性。养老护理行业受到政府的严格监管，政策的变化可能对公司的经营带来不确定性。随着行业监管的日益严格，悦心健康需要投入更多资源以确保合规，这将增加公司的运营成本。尤其是在安全管理和服务质量控制方面，公司需严格遵守相关法律法规和行业标准，确保老年人的健康与安全。

总之，头部企业凭借其专业的人才培养体系、智能化的养老服务、多元化的服务体系和良好的品牌形象，在养老服务行业内具备显著优势。然而，行业的资本密集性和人力资源短缺问题，以及市场竞争、政策变化等威胁，是企业需要关注的挑战。

3.2.3. 公司选择：文化、人才、服务构成核心竞争力

现代以来，“养老”很难再被看作一项一体化的任务来完成。消费社会的兴起、养老产业和服务业细分让“孝道”被具象化为实体产品和无形服务，**一些产品和品牌开始被赋予孝老属性和情感符号，推动了孝道文化的再造。**

以悦心健康为例，悦心健康秉持吸取中西文化精粹，发扬中华传统文化与人文哲理思想，深切体会人应该被同理对待，并有着追求身体与心灵相互平衡的需要。同时坚守医疗和健康照护的标准，用「视您如己，全心关爱」的心对待每一位客户，**努力成为富有温度关怀的体现、人文关怀的典范。**在公司的上海奉贤金海悦心颐养院中，公司将高品质养老机构的专业水平与照护品质引入到社区养老机构，以“老吾老以及人之老”作为核心理念，设有亲子娱乐空间

和咖啡茶室，让亲属可以更好的陪伴老年人。同时，颐养院还开设了远程探望“云见面”服务，让无法到现场的子女和老年人“云见面”，让亲情不断线。悦心认知康复研究中心为认知症长者提供更为专业的康复服务。对认知症老年人倡导非药物治疗，重视人与人的交流，综合老年人的状态，并结合亲情、艺术、运动、怀旧、园艺五大非药物治疗方法，建立了认知症长者的特色健康照护体系。理解、尊重认知症长者，用专业的护理、真诚的关怀、耐心的服务，为长者营造更适合的生活环境，让他们的晚年生活过得更有尊严。

在探讨老年护理如何与孝文化巧妙结合时，某企业推出的趣味捶背互动产品提供了一个创新的视角。这款产品将传统的孝道与现代设计理念相结合，通过游戏化的方式，鼓励小朋友主动为老年人提供捶背服务。在这个过程中，老年人手中的动物图案卡片指示小朋友在背上寻找对应的动物贴图，而这些贴图点位是依照中医穴位布置的。当敲击这些点位时，产品会发出不同动物的叫声。通过这种互动，年轻人能够更加了解老年人的需求，同时也能够体验到照顾长辈的快乐和满足感。随着社会的发展和科技的进步，本研究期待看到更多类似的创新设计。

孝道文化传统为探索“中国式”老年照护模式提供了丰沛的思想资源，为悦心健康构建具体的照护服务体系提供了基本的理念构型。作为借鉴，未来老年护理行业的公司应当继续关注乡土社会中家庭和社区的文化价值，发展活力养老、文化养老、健康养老、智慧养老，发展新时代的孝文化。

3.2.4. 公司人才战略和产品矩阵创新

头部企业的重要共同点之一是**积极利用多种途径吸引人才。**通过企业官网发布招聘信息并与各大招聘网站合作，扩大招聘覆盖面，确保更多潜在人才了解公司的招聘需求。此外注重与高校、职业院校建立长期合作关系，开展校园招聘活动，针对养老护理、康复治疗技术、老年服务与管理等相关专业的学生进行定向招聘，为公司储备专业对口的年轻人才。

在**人才选拔**过程中，举例而言，悦心健康制定了严格的标准。注重考察其沟通能力、耐心、爱心以及对老年人的关怀意识。例如，在面试环节，会设置情景模拟题，要求应聘者模拟与老年人沟通交流或处理突发状况的场景，以此评估其实际应对能力和服务态度。

而且，为了高效吸纳并留住护理人才，头部公司很多都实施了**总部抓制度、分部抓实操**的策略，确保服务质量的统一和高标准。具体而言，对于新入职的护理人员，开展涵盖基础护理技能、老年人生活照料规范、常见疾病护理要点等内容的入职培训，确保其能够快速适应工作岗位。后逐渐提供进阶培训课程，如慢性病管理、康复护理技术、老年人心理护理等，以提升员工的专业水平。员工可以根据自身的兴趣和能力，选择在专业技术领域深入发展，如从初级护理人员晋升为高级护理专家，或者在管理岗位上逐步晋升。清晰的职业发展路径激励员工不断提升自己的专业能力和综合素质，为公司的长期发展留住人才。

服务矩阵方面，依托自身的医疗机构，头部企业往往会选择**组建一支专业的医疗团队**，包括医生、护士、康复治疗师等。这些专业人员为养老机构中的老年人提供全方位的医疗服务，确保老年人的健康问题能够得到及时、有效的解决。同时，医疗团队还与养老护理人员密切配合，为老年人制定个性化的健康管理方案，实现医养无缝对接。有的企业正致力于完善其科学体检中心、创新医学中心、康复养生中心三板块，以**把握行业医康养基本盘**。科学体检中心作为预防性医疗服务的重要组成部分，能够为老年人提供定期的健康检查和疾病筛查，从而实现早期发现和干预。创新医学中心则侧重于应用最新的医疗技术和研究成果，为老年人提供更为精准和个性化的治疗方案。康复养生中心则关注于老年人的康复训练和养生保健，通过专业的康复服务和养生指导，帮助老年人恢复身体功能，提高生活质量。

针对不同需求的老年人，企业正不断尝试**推出多样化的养老服务产品**。例如，为生活能够自理的老年人提供活力养老社区服务，社区内配备各种休闲娱乐设施和活动场所。对于半自理和不能自理的老年人，提供专业的护理服务，包括生活照料、康复护理、特殊疾病护理等。并根据每个老年人的生活习惯和兴趣爱好，为其制定个性化的服务方案。例如，对于患有糖尿病的老年人，在饮食方面会提供专门的糖尿病饮食方案；对于喜欢阅读的老年人，会在房间内配备适合的阅读设备和书籍。还有企业通过建设养老度假小镇，配合长护险定价，抓住行业产旅融合长点。这种模式不仅能够为老年人提供舒适的居住环境，还能够结合旅游和休闲资源，丰富老年人的精神文化生活，同时也为企业带来新的收入来源。



4.策略展望

全链路护航老年护理，逐个击破行业瓶颈



4. 策略展望——全链路护航老年护理，逐个击破行业瓶颈

4.1. 政府职能清晰化

宏观来看，首要之义是**厘清政府与市场的职能边界，将养老事业和养老产业进一步区分，发挥市场在私人产品以及政府失灵领域发挥资源配置的决定性作用。**

聚焦政府，需从标准化和强智能化两方面调整政策目标。深化老年护理服务标准、技术参数和信息安全规范，鼓励形成区域行业协会，建立行业监督和信息交流机制；加强人工智能技术的深入应用，精准预测未来养老服务需求趋势，提升服务可获得性和质量；调整环境型政策工具，增加经济型政策力度；优化供给型政策工具，加快复合型专业人才培养；增加需求型政策工具，强化政府采购和服务外包，开展技术交流；实现间接性政策工具与直接性政策工具的相辅相成，策略型措施与配套性措施的匹配协同，提升政策工具效能。

切分地区，针对长三角、粤港澳等集群，应在《长三角区域一体化发展规划纲要》等政策框架下，**构建养老新格局**。通过主体联合协同、整体规划引导和工具匹配应用，形成区域养老服务与老年护理的新体系。依据 2019 年 7 月国务院办公厅发布的《关于同意建立养老服务部际联席会议制度的函》，地区应明确核心部门地位，确立民政、卫健和工信部门在智慧养老部级联席会议制度中的核心地位。**整合资源要素**。充分整合核心机构与非核心机构间的资源，突破部门行政壁垒，构建协调型主体网络。制定长期规划：民政、卫健和工信部门基于区域智慧养老服务的发展水平、定位和资源禀赋，联合制定长期规划，取长补短。

此外，从容应队针对这一痛点，还特别提出三方面举措。

4.1.1. 畅通老年护理事业意见反馈渠道，搭建老年护理产业服务评价平台

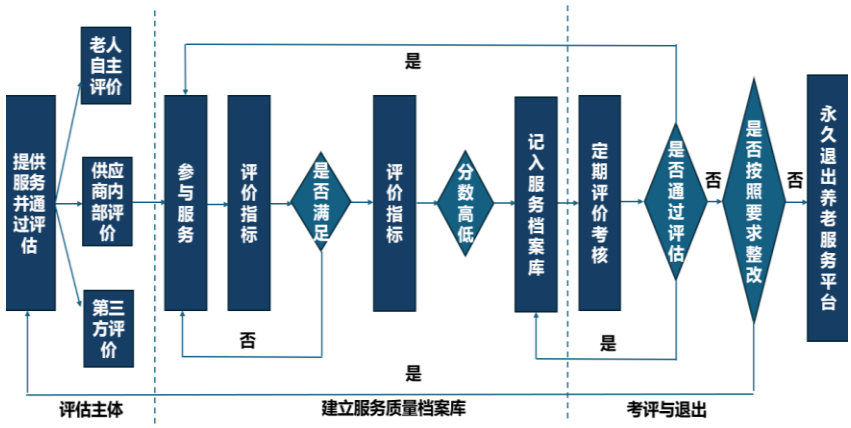
通过精心**搭建一个专注于养老产业服务评价的综合平台**，不仅能更好区分并强化养老事业与养老产业的不同侧重点，还能有效提升服务质量和行业透明度。

在养老事业方面，**意见反馈渠道的畅通**是保障老年人权益、优化服务内容的关键。通过设立多渠道反馈机制，如热线电话、在线平台、实体意见箱及定期座谈会等，可以广泛收集老年人及其家属对于养老服务的直接感受与改进建议。这些反馈将作为调整服务策略、完善服务流程的重要依据，确保养老事业能够更好地满足老年人的多元化需求，体现其公益性与服务性的本质。

而在养老产业层面，**搭建一个公正、透明的服务评价平台**则显得尤为重要。该平台应涵盖养老服务的各个方面，包括但不限于居住环境、医疗护理、精神慰藉、文化娱乐等，通过用户评价、第三方评估及行业标准的综合考量，为养老服务机构提供全面、客观的评价体系。这不仅能够促使养老产业内的服务机构不断提升服务质量，增强市场竞争力，还能为老年人及其家庭在选择养老服务时提供可靠的参考依据，推动养老产业向更加专业化、标准化、人性化的方向发展。

总之，**畅通养老事业的意见反馈渠道与搭建养老产业的服务评价平台，是推动养老服务体系高质量发展的两大支柱。**两者相辅相成，既保障了养老事业的公益性与服务性，又促进了养老产业的健康有序发展，共同为实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安的养老目标贡献力量。

图35：服务评价平台模式图

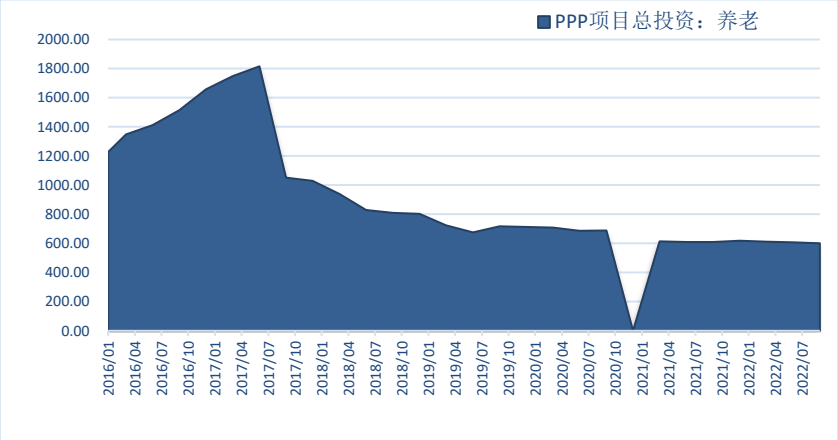


资料来源：公开资料整理

4.1.2. 推动公私合作新范式（PPP）

PPP（Public-PrivatePartnership，公私合作伙伴关系）模式是一种创新的合作机制，它通过政府和社会资本的合作，共同投资、建设和运营老年护理设施和服务。这种模式的核心在于利益共享和风险共担，旨在提高公共产品或服务的质量和供给效率。在老年护理领域，PPP 模式可以采取多种运作方式，如 BOT（建设-运营-移交）、BOOT（建设-拥有-运营-移交）等，通过特许经营权、合理定价、财政补贴等手段，引入社会资本参与投资和运营。

图36：PPP 模式对养老产的支撑作用亟待提升



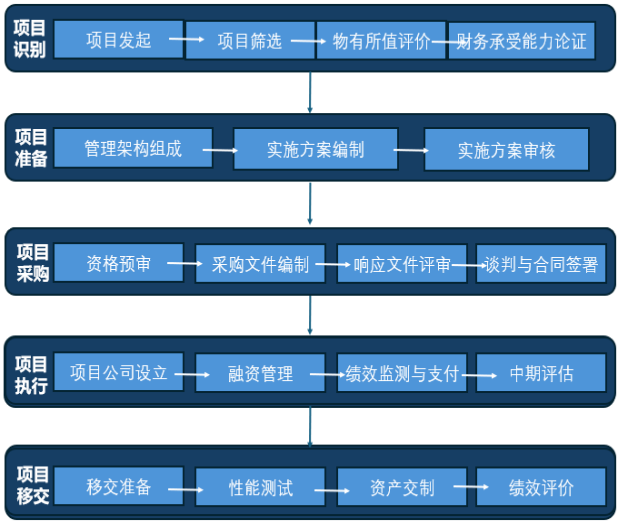
资料来源：财政部全国 PPP 综合信息平台项目库

这一应用在减轻政府的财政负担的同时，能有效激发社会资本的参与热情。例如，通过 PPP 模式，可以建立医养结合的养老服务机构，提供日常照料、心理疏导、医疗康复等服务，并通过使用者付费和政府补贴相结合的方式获得补偿。此外，PPP 模式还可以促进智慧养老平台的建设，通过现代信息技术手段，提高养老服务的质量和效率。

具体实施方面，首先要**及时梳理并更新阻碍 PPP 发展的旧规**，推动更高层次的法律制定，减少法律条文、部门规章与规范性文件间的断层。同时加强跨部门间的协同合作，建立高效的监管协调机制，打破当前“多头管理”的碎片化格局。

其次，**完善 PPP 模式的配套支持体系，形成一套科学系统的 PPP 操作流程，为项目的顺畅推进铺设道路**。

图37：PPP 操作流程



资料来源：财政部

4.1.3. 关注公办养老机构的“公建民营”模式

“公建民营”模式是一种创新的养老服务路径，旨在提升特困人员供养服务机构的服务质量和效率。推进这一社会化改革，被视为特困人员供养服务机构转型升级的关键策略之一。有专家指出，“公建民营”的社会化改革采取政府与社会资本合作的模式，充分发挥双方的互补优势，专为特困人员提供护理型供养服务，并拓展至为公众提供护理型养老公共服务。

在确保公办养老机构国有性质不变的前提下，该模式通过将机构整体打包并委托给专业公司运营，能够有效解决公办养老机构面临的管理体制僵化、服务功能单一、资源分配与利用不均衡等问题。

尽管“公建民营”改革模式目前仍处于探索阶段，但从已实施的案例来看，养老机构在面貌和服务能力上均有望得到显著改善。然而，这一模式在推进过程中也面临诸多挑战和问题。例如，如何在保障特困养老年人员生活质量的同时，实现运营企业的盈利目标？政府在将养老机构委托出去后，应如何重新定位自身的角色？这些问题均需要进一步深入探索和规范。

为了推动“公建民营”模式实现政府资源有效利用、专业社会组织充分发展以及入住老年人享受高水准服务的“三赢”目标，本研究需要借鉴成功的改革经验。

昌黎县公办养老机构在“公建民营”改革中的做法便提供了有益的参考。昌黎县政府在将养老机构委托出去后，职能定位从直接管理转变为承担监管责任，并对合作运营内容进行了明确和规范。

在未来的改革工作中，**政府需要继续探索更有效的监管机制，并制定更完善的准入准出机制、评估考核体系以及运营风险保障机制。**同时，**运营企业也应承担起应有的责任，在运营公办养老机构的过程中认真总结经验、完善各项制度，切实履行福利事业发展的社会责任。**政府应引导资本市场、软硬件厂商、服务提供商和行业专家的共同参与，推动健康服务与保险、旅游、养老、健身、智能制造等产业的融合发展。通过培育创新创业氛围、建立有效制度环境，更好满足人民群众多样化的服务需求。

4.1.4. 乡村地区老年护理产业亟需建设

由上文的实证分析可知，乡村地区家庭护理供给严重不足，传统的家庭照护

模式受限于人口流动、代际关系与经济条件的变化已无法满足老年人日益增长的护理需求。这种状况对乡村老年人的生活质量、健康状况以及社会稳定性产生了深远影响。

要解决这一问题，需要在国家层面出台针对性的支持政策。建议政府通过立法、财政补贴和税收优惠等方式，鼓励社会资本和企业进入乡村老年护理领域。具体措施包括：

1. **制定专门针对乡村地区的老年护理政策**，明确政府、家庭、社区和市场在老年护理服务中的责任与义务，确保政策覆盖到偏远和经济落后地区。

2. **加大财政支持力度**：设立专项基金，为乡村地区的护理服务提供补贴，并优先支持经济困难家庭、失能老人和空巢老人。

3. **优化资源分配机制**：推动城乡资源均衡化，确保乡村地区在护理设施建设、医疗资源分配和护理人员培训等方面不落后于城市。

4. **推动乡村医疗机构与养老服务机构深度融合**，在乡镇卫生院、村卫生室基础上，增加护理床位和专业护理人员配置，为老年人提供一体化的健康管理与护理服务。

5. **促进乡村护理服务的本地化**：引导乡村地区发展本地的中小型护理服务企业，利用乡村劳动力发展规模化、标准化的护理服务，从而既满足老年人护理需求，又带动农村就业。

6. **鼓励社会力量参与**：动员社会组织、公益团体和志愿者积极参与乡村老年护理服务，形成政府、家庭和社会“三位一体”的护理服务格局。

由于乡村地区的经济水平、社会结构和文化传统存在较大差异，建议以试点示范的方式推进护理服务体系建设：首先选择有代表性的乡村地区开展老年护理试点，探索符合当地实际的护理服务模式。定期对试点项目的实施效果进行评估，总结成功经验与不足，为下一步推广提供参考依据。在试点经验的基础上，因地制宜地推广适合不同乡村地区的护理服务模式，确保政策的可行性和可持续性。

通过政策支持，有望有效缓解乡村老年护理供需失衡的局面，逐步建立起覆盖广泛、服务优质、运行高效的乡村老年护理体系。这不仅有助于改善乡村老年人的生活质量，也将为乡村振兴和社会稳定提供有力支撑。

4.2. 养老服务社会化

随着人口老龄化的加剧，我国失能老年人群体规模逐渐扩大，这一群体的护理需求明显高于健康老年人。然而，由上文实证分析显示，在失能组中，自身及子女的受教育程度对亲子互动的促进效应逐渐减弱，这也揭示出传统家庭护理模式难以适应长期失能护理需求的现实困境，即“久病床前无孝子”问题。与此同时，老年护理行业应从“被动护理”向“健康促进”转变，聚焦老年人健康管理、预防失能，降低老年群体对高强度护理服务的需求负荷。因此，基于“养老服务社会化”的理念，综合“医养结合”和“大健康意识”，力求从根本上改善失能老年人的护理困境，并为健康老龄化提供可持续的解决方案。

1. 推进医养结合模式，构建多层次健康养老服务体系。医养结合是解决失能老年人护理需求的重要途径，其核心在于将医疗服务与养老服务深度融合，为老年人提供从预防、护理到康复的全生命周期健康管理服务。

（1）在乡村和社区层面，推动基层医疗机构（如卫生院、社区医院）与养老服务机构（如养老院、日间照料中心）深度合作，建立“医中有养、养中有医”的服务机制。通过设置护理床位、配备专业护理团队，为失能老年人提供长期护理、康复治疗和健康管理服务，减轻家庭护理负担。

（2）在政策层面，优先为失能老年人提供长期护理保险覆盖，降低其就医和护理成本。同时，在护理服务中引入专业医疗支持，如定期上门巡诊、远程健康监测等，以确保失能老年人能够及时获得高质量医疗服务。

（3）鼓励在社区和乡村设立“嵌入式”医养结合机构，即在社区养老机构中增加医疗服务功能，或在医疗机构中设置养老护理专区。这种模式既能满足老年人对就近养老的需求，又能保证医疗服务的可及性。

2. 提升老年人健康意识，推进“健康促进型”养老理念。传统养老模式往往以“护理失能”为核心，而忽视了健康管理和疾病预防的重要性。通过倡导“大健康”理念，可以在老年人群中建立健康促进意识，从源头上减少失能的发生，缓解护理需求压力。具体措施包括：

（1）推动健康教育进社区

依托社区卫生服务中心、老年大学等平台，定期开展针对老年人的健康讲座和培训，普及健康生活方式、慢性病管理和失能预防知识。重点针对高龄老年人及其家属开展健康管理培训，使家庭成员能够主动参与老年人的健康维护。

（2）推广“家庭健康档案”管理

为老年人建立全面的“家庭健康档案”，记录其健康状况、慢性病史和生活习惯。通过定期更新健康数据，便于医疗机构为老年人提供个性化的健康管理方案，同时实现健康预警和早期干预。

（3）发展老年人健康促进活动

在社区或乡村推广适合老年人的健康活动，如太极拳、健步走、广场舞等，激励老年人参与日常运动，提升身体素质。通过组织健康比赛或活动，可以增强老年人群体的健康意识，提高生活质量。

3. 加强养老服务社会化，整合多元化社会资源。养老服务社会化的核心在于充分整合政府、市场、社会组织以及家庭的力量，共同搭建覆盖健康老龄化的服务网络。

（1）引导社会资本进入医养结合领域

通过政策激励（如税收减免、专项补贴等），鼓励社会资本投资建设医养结合型养老机构和健康管理中心，扩大失能老年人的服务选择。同时，支持社会企业开发智能化养老设备（如健康监测手环、智能护理床等），为老年人的护理与健康管理提供技术支撑。

推动护理资源共享与互助机制

在社区层面，尝试建立“护理时间银行”模式，即健康老人或家庭成员通过参与护理服务积累“护理时间”，未来可以兑换同等护理服务。这种模式不仅能激励更多人参与养老服务，还能提高护理资源的利用效率。

4. 倡导代际和谐，强化家庭护理支持。虽然“久病床前无孝子”反映出家庭护理的现实困境，但家庭仍是老年人护理的核心力量。为此，应通过政策和社会支持，强化家庭在养老服务中的基础作用：

（1）推广家庭护理培训计划

针对失能老年人的家庭成员开展护理技能培训，使其具备基本的护理能力。同时，通过心理辅导和情感支持，缓解家庭护理者的心理压力。

（2）实施家庭护理补贴政策

为长期照护失能老年人的家庭提供经济补贴，或将家庭护理纳入长期护理保险范畴，减轻家庭的护理负担。

（3）加强家庭与社区的互动

鼓励家庭成员参与社区组织的养老活动，通过交流与互动，增强家庭成员的护理信心和责任意识。

失能老年人的护理需求是当前养老服务体系中的重点和难点。通过推进“医养结合”、倡导“大健康意识”、整合社会资源以及提升护理服务专业化水平，可以从根本上减轻失能老年人的护理负担，实现老年人群体的健康老龄化。这一策略不仅能满足失能老年人的护理需求，还能推动养老服务的社会化和可持续发展，为应对人口老龄化挑战提供有效路径。

要推动养老护理行业的社会化进程，还需要从政策引导和社会认可两方面着手。国家应加大对养老护理行业的政策支持力度，出台更多鼓励措施，推动养老机构的专业化和标准化发展。除了已经在推进的养老机构税收减免、补贴等经济激励措施，更要加快建立健全完善的老年护理服务质量标准体系。与此同时，媒体应积极引导社会舆论，改变“送老年人去养老院是不孝”的传统观念。通过宣传优秀的养老护理案例、报道老年人在养老机构中的幸福生活，提升社会对养老机构的认可度，让大众接受“养老是多元化、社会化的服务体系”这一理念。

其次，建立护理机构与家庭的情感共育机制是避免情感责任角色错位的应有之义。具体而言，可以从以下几方面入手。

1. 家属参与的制度化。养老机构可以制定明确的家属参与机制，定期组织家庭探视日、家庭参与护理计划设计的讨论会等活动，使家庭成员能够更有参与感和责任感，减少老年人对被“遗弃”的负面情绪。同时，护理机构可以为家庭成员提供护理培训，让他们在探视或短暂居家护理时具备基本的护理技能，给予老年人更多支持。

2. 做好“情感桥梁”的角色。护理机构不应试图承接子女的情感责任，而是要扮演好“桥梁”的角色。通过定期为老年人和家庭成员组织线上或线下的交流活动，促进家庭之间的联络。护理人员可以帮助老年人记录生活点滴，定期与家属分享，让家属能够了解老年人的生活近况，增加情感联系。

3. 明确划分情感关怀与专业护理的责任。护理人员应接受有关情感支持的培训，学习如何在照护过程中以尊重、倾听为基础，提供适度的情感支持。通过引入心理咨询师、社工等专业人员，定期为老年人提供情感支持和心理疏导，帮

助他们应对孤独、焦虑等常见情绪问题。机构还可以尝试打造“情感附加值”服务。在专业护理服务之外，提供情感支持、心理慰藉和人格尊重的关怀服务，不仅能弥补老年人情感需求的缺口，还可以提升养老机构的服务质量和口碑。如根据老年人的生活经历、性格、兴趣爱好等，设计符合其需求的关怀方式，倾听他们的意见，帮助他们参与决策，赋予他们在养老院生活中的主动权，提升老年人的自我价值感。

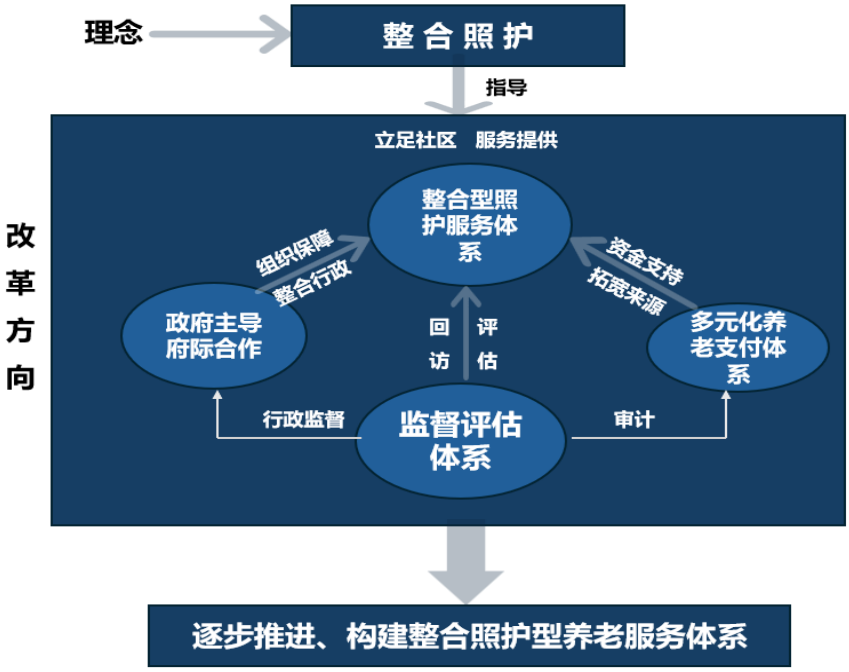
通过在政策与社会认可、情感共育机制、情感附加值服务等方面的深入挖掘，养老服务社会化可以逐步化解当前文化与伦理的冲突。在尊重老年人自立性与家庭情感的基础上，护理机构应主动调整角色定位，提供兼具情感关怀和专业护理的服务，推动养老模式向更加灵活、社会化的方向发展。

4.3. 产业纵向整合化

针对养、护、医、送四大功能的分离这一痛点，产业纵向整合化是关键的解决策略。通过整合养老服务的各个环节，实现资源的优化配置和服务的无缝对接，以提供连续、协调的养老服务体验。

整合照护模式是应对人口老龄化的必然选择，值得学习和借鉴。较早面对老龄化挑战的西方国家已发展出了一套更为成熟的“整合照护”理念体系。整合是一个涉及资金、行政、组织、服务提供等一系列因素的连续过程，旨在使医疗、照护等部门间建立深度的联系与协作，最终目标为提高护理质量、生活质量、老年人满意度及服务效率，解决跨越多类服务、多个提供者和不同环境的老年人的长期照护问题[12]。

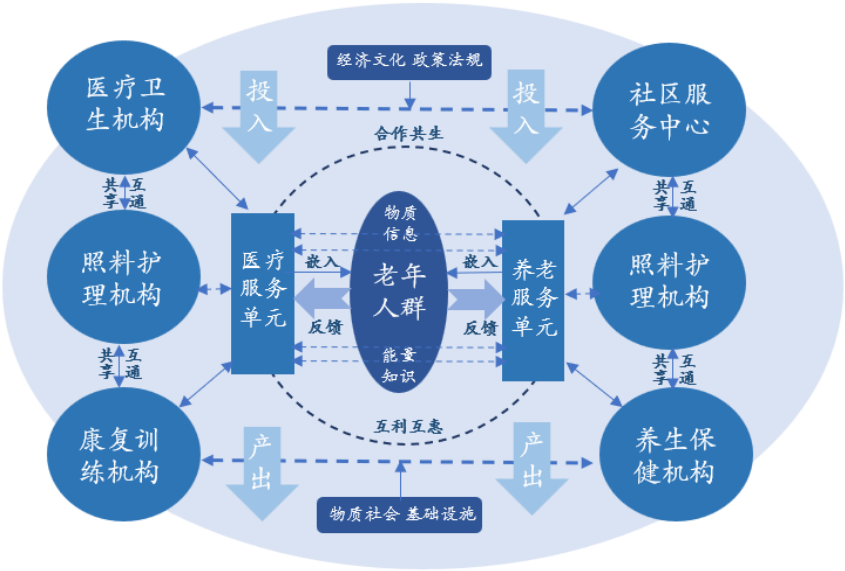
图38：整合照护模式



资料来源：公开资料，从容应队整理

具体而言，首先需要加强养老服务机构与医疗机构的合作，推动医养结合模式的发展。通过建立绿色通道、合作共建、远程医疗等方式，使老年人能够便捷地获得医疗服务。其次要推动养老服务与居家服务、社区服务的融合。通过建立综合性的养老服务平台，整合家政、餐饮、娱乐、教育等多元化服务，为老年人提供一站式的养老服务解决方案。这种整合有助于提高养老服务的便捷性和可及性。最终搭建一个高度协作的“医康养护”共生服务的养老产业链。

图39：“医康护养”共生产业系统



资料来源：公开资料，从容应队整理

4.4. 企业多元竞争化

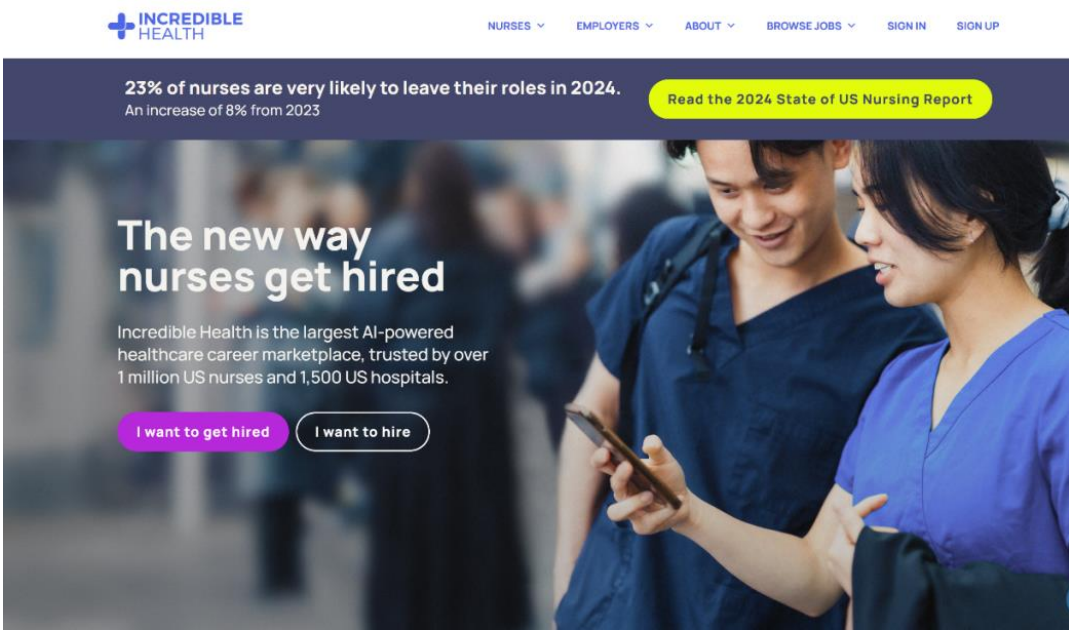
4.4.1. 人才来源多元化

在当下护理人才紧缺的背景下，**构建和优化员工服务或将成为突破“用人难”困境的关键所在**[16]。实际上，国外养老服务企业在这一方面已有成功先例。

1.人才培养：丹诺康作为全国布局的养老服务品牌，在人员的培训及管理上实行「两级培训体系」和「三级质控系统」。「两级培训体系」即公司总部和区域分部对于员工的培训内容侧重不同。总部培训内容侧重于政策、制度、监管，区域分部则侧重于护理工作中的实操内容。「三级质控系统」即在内部专门设立培训质控部门，该部门的相关人员会对总部、区域分部、下属护理站的培训内容及效果进行严格质量把控。该模式下，培训内容有侧重，培训质量有保证，有效提升企业护理员的培养效率和质量，为企业向市场输送高素质护理人才奠定基础。

2.人力资源管理：美国医疗保健招聘平台 IncredibleHealth 的成熟模式或将为我国护理行业的人力资源管理提供新的思路。

图40：海外企业的人力管理



资料来源：IncredibleHealth 官网

（1）用“平台预筛选+候选人反选”模式吸纳人才

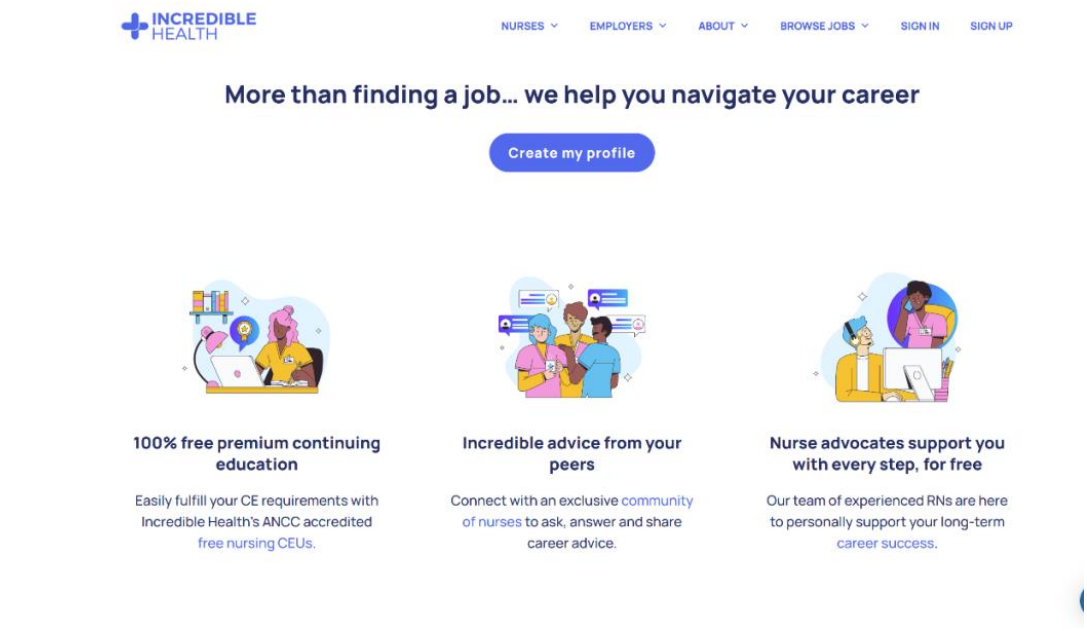
IncredibleHealth 开创了一种自定义匹配算法，实现招聘速度更快、效率更高，大大缩减用人单位成本，帮助护士找到更匹配、更长久的工作岗位。

首先，平台会对候选人进行预筛选，确定符合标准的申请者。不同于传统招聘模式的是，该平台将候选人与医院的角色互换，让医院向平台上合格的候选人发送面试请求，同时，平台会自动在短信、电子邮件及 APP 中展示医院页面，以供候选人决定是否参加面试。在该模式下，医院的招聘效率得以提升 25 倍。

（2）用有效关照留住人才

由于高强度的工作和较为压抑的工作环境，护理人员需要承受较大的身心压力，这也就带来了护理行业人才流动性高的问题，美国护士群体也有着类似的处境。为了帮助护士应对压力、缓解倦怠，IncredibleHealth 开发了护士健康工具包，其中包括两种产品。护士免费在线社区：护士可以在社区匿名发帖，不用担心雇主看到内容。社区话题从如何在专业之间转换的建议到应对倦怠的策略，也有各种轻松对话。每日护士日志：一个免费的数字日志平台。护士们可以用结构化的每日提示，来记录自己的情绪，以帮助他们更有效地处理压力。

图41：海外企业的员工关怀



资料来源：IncredibleHealth 官网

当护士在寻找新的岗位时，平台除了能够完全实现自动匹配和调度外，还配备了“人才倡导者”的角色，帮助规划职业生涯、提供面试指导、评估工作选择，并分享简历技巧。相比之下，我国当前的护理员匹配机制和信息交流平台尚不完善[14]，使得患者和医院在寻求专业且值得信赖的护理员时面临挑战。因此，**如何更加高效地吸纳并留住护理人才，将成为养老服务企业下一步需要完成的重要**

课题。

4.4.2. 服务产品多元化

服务是产品就要有服务的产品线，且产品线要针对不同市场、客户开发和设计。企业可以放眼海内外竞对的业务范围，结合我国消费者层次多元的特点。以用户体验思维设计产品，以共赢的理念打造服务产品，以精品服务让渠道实现服务产品的落地。

表17：他山之石——海外类似公司的业务范围

公司	业务范围
Koninklijke Philips N.V. (荷兰)	提供医疗保健技术和服务，包括老年护理解决方案。
Amedisys (美国)	提供家庭健康护理和临终关怀服务。
ECON Healthcare Group (新加坡)	提供医疗保健服务，包括老年护理。
Encompass Health Corporation (美国)	提供康复服务和家庭健康护理。
EXTENDICARE (加拿大)	提供长期护理和退休生活服务。
LHC Group, Inc. (美国)	提供家庭健康、个人护理和临终关怀服务。
Medtronic (爱尔兰)	提供医疗设备和解决方案，包括针对老年人的健康监测和治疗设备。
ORPEA GROUPE (法国)	提供护理和康复服务，包括老年护理。
Prolifico (印度)	提供医疗保健服务，包括老年护理解决方案。
ElderCareCanada (加拿大)	提供老年护理和支持服务。
Right at Home, LLC (美国)	提供家庭护理和支持服务，帮助老年人在家中安全生活。
BAYADA Home Health Care (美国)	提供各种家庭健康护理服务。
United Medicare Pte Ltd (新加坡)	提供医疗保健服务，包括老年护理。
Trinity Health (美国)	提供综合医疗服务，包括老年护理。
Rosewood Care Group (澳大利亚)	提供老年护理和退休生活服务。
ST LUKE'S ELDERCARE LTD (新加坡)	提供老年护理服务。
FC Compassus LLC (美国)	提供临终关怀和家庭健康护理服务。
Home Instead, Inc. (美国)	提供家庭护理服务，帮助老年人在家中生活。
Interim HealthCare Inc. (美国)	提供各种家庭护理服务。
Living Assistance Services (加拿大)	提供家庭护理和支持服务。

资料来源：从容应队整理

具体而言，本研究认为企业需要做好：

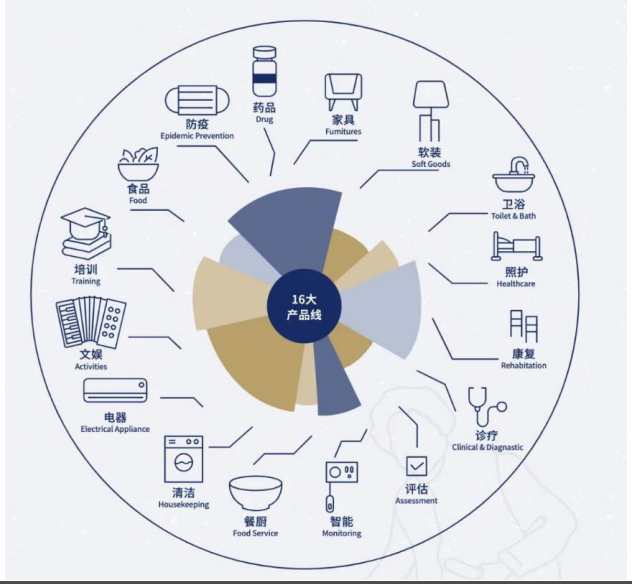
1.年龄差异化：根据低龄（60-69 岁）、中龄（70-79 岁）、高龄（80 岁及以上）老年人的不同需求，设计差异化的护理服务。低龄老年人更注重社交和文化活动，企业可以开发以社交活动、心理关怀、健康管理为主的服务产品。而高龄老年人则更需要日常照料和医疗护理，企业可以加强基础护理和疾病管理服务。

2.性别差异化：根据男性和女性老年人在健康状况、生活习惯、心理需求等方面的差异，设计专门的护理服务产品。男性老年人更关注独立性和个人尊严感，企业可以提供更加自主的护理方案，而女性老年人可能更注重情感支持和社交互动，企业可以设计更多的社交和心理支持服务[15]。

3.疾病管理多元化：针对患有不同疾病的老年人，企业可以开发专门的护理服务。例如，针对慢性病患者，企业可以提供定期健康监测和个性化康复指导；对于阿尔茨海默症患者，则可以设计认知训练、特殊饮食和环境安全管理等专门

护理方案。

图42：老年护理企业 16 个可能的服务产品线



资料来源：IncredibleHealth 官网

4.4.3. 技术创新多元化

利用技术创新提升服务差异化和应对复杂护理需求。老年护理企业应当主动开展产学研融合，利用数智化技术对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，实现技术与老年人的友好交互，不仅提升老年人的生活质量，而且利用好老年人的经验，使智慧科技和智慧老年人相得益彰，帮助老年人更多地参与社会，尽可能地增强独立性，使老年人生活得更幸福、更有尊严、更有价值。

图43：2019 中国设计智造大奖佳作奖便携式电动折叠轮椅



资料来源：中国设计智造大奖

图44：2021 中国设计智造大奖佳作奖悠行 220 外骨骼机器人



资料来源：中国设计智造大奖

图45：安康通智能工单系统



资料来源：安康通官网

图46：柔性皮肤医疗协助机器人

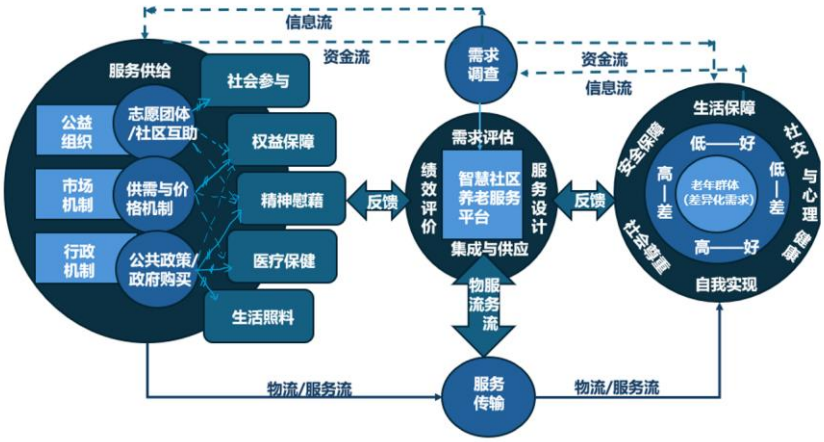


资料来源：2022 日内瓦发明展银奖作者：王菲、杨赓、周志杰、李健

4.4.4. 服务渠道多元化

拓展服务渠道，丰富供给主体。搭建线上护理服务平台，通过线上平台老年及其家属可以随时获取护理建议，预约专业护理人员的服务，甚至通过远程视频进行身体检查和心理辅导。同时企业在社区中设立多个护理服务站点，提供日常护理、健康管理和康复服务。线上平台和线下站点的融合可以为老年人提供更加灵活和便利的护理服务。

图47：多元供给模式图



资料来源：从容应队整理

5.效果预测与风险评估

长风破浪会有时，风物长宜放眼量



5. 效果预测与风险评估——长风破浪会有时，风物长宜放眼量

5.1. 效果展望:老年护理行业的三个“5”

通过逐步解决行业痛点，老年护理行业将迎来进一步发展。以下分别以 25 年、35 年、45 年为时间节点，对老年护理产业阶段性发展进行展望与规划。

第 1 阶段：2025 年（近期展望）：

根据《全国护理事业发展规划（2021-2025 年）》，2025 年，我国护理事业发展的主要目标是全国护士总数达到 550 万人，每千人口注册护士数达到 3.8 人[16]。这一阶段的重点在于：

1. **优化护理资源布局：**结合人口结构变化和群众医疗护理服务需求，健全覆盖急性期诊疗、慢性期康复、稳定期照护、终末期关怀的护理服务体系。

2. **增加护理服务供给：**推动医疗资源丰富地区盘活资源，增加基层医疗机构提供护理、安宁疗护等服务的床位数量。

3. 推动护理高质量发展，创新护理服务模式，如“互联网+护理服务”，加强护理学科建设。

第 2 阶段：2025 年--2035 年（中期规划）：

到 2035 年，预计老年护理行业将实现更深层次的变革。

1. **智慧养老的普及：**随着物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合，智慧养老将成为主流趋势，为老年人提供更加便捷、个性化、安全的服务体验[17]。

2. **护理人员专业化培训：**通过加强职业教育与培训，培养具备专业技能与人文关怀精神的护理人员，建立专业的心理咨询与辅导团队。

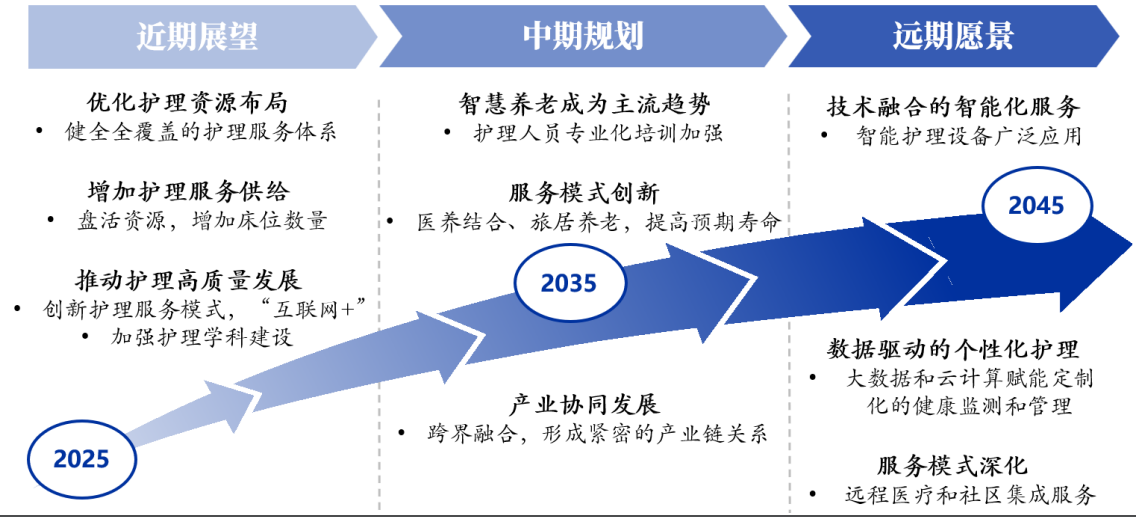
3. **服务模式创新：**养老护理行业不断创新服务模式，如医养结合、旅居养老等，更加注重疾病的早期干预与康复护理，提高老年人的生活质量与预期寿命。

4. **跨界融合：**养老护理行业将与其他相关行业，如美容、旅游等形成紧密的产业链关系，共同推动产业的协同发展。

第 3 阶段：2035 年--2045 年（远期愿景）：

到 2045 年，老年护理行业预计将达到全面成熟阶段，迎来技术融合与模式创新的黄金时期，将逐步推广**全面智能化服务**（智能护理设备和系统将广泛应用于老年护理中，极大提高服务效率和质量）、**个性化护理方案**（于大数据与云计算的健康管理平台内实现更大范围内的健康数据共享与分析，为老年人提供更加精准的健康管理与疾病预防服务）等。

图48：行业发展宏观规划



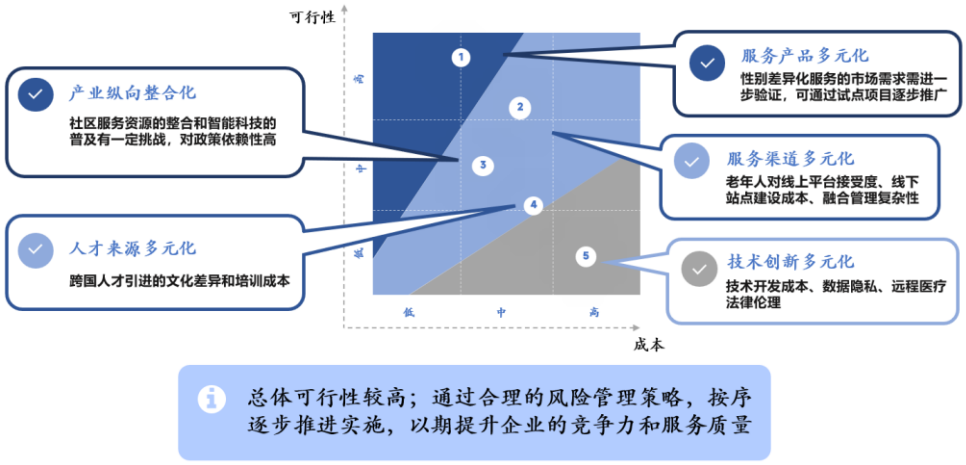
资料来源：从容应队整理

综上所述，老年护理产业在 2025-2045 间将经历从技术创新到人文关怀，再到全面智能化的深刻变革[18]。通过不断发展，老年护理产业将为老年人提供更加优质、高效、贴心的服务，为构建和谐社会、实现健康中国目标贡献力量。

5.2. 运作风险矩阵及可行性探讨

任何战略的实施都伴随着潜在的风险。为了更好地理解这些风险，并评估其可行性，以下将对本研究的策略进行风险矩阵分析，探讨每项策略的可行性。

图49：策略风险总览

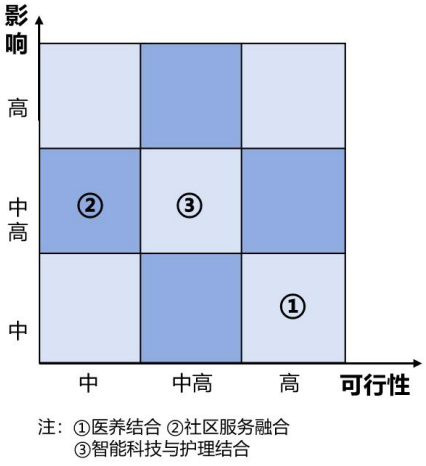


资料来源：从容应队整理

产业纵向整合化具有较高的可行性，但社区服务资源的整合和智能科技的普及面临一定挑战，需要逐步推进并赖于政策支持，需要通过建立合作机制，逐步扩大服务范围和技术应用。

图50：产业纵向整合化风险矩阵与可行性探讨

因素	风险	影响	风险	可行性分析
医养结合	医疗机构与养老机构的合作协调难度大，利益分配不均导致合作失败	中	建立长期合作协议，制定清晰的利益分配机制，确保双方利益一致	高：医养结合能够提升服务质量，减轻医疗负担，具有较高可行性
社区服务融合	社区服务资源有限，整合难度大，服务标准化难以实现	中高	与社区组织合作，逐步扩大服务范围，制定统一的服务标准和流程	中：社区服务的推广需要时间，但可以提升服务的可及性和便利性
智能科技与护理结合	智能科技的应用成本高，老年人对新技术的接受度低	中高	提供简化版智能设备和技术培训，逐步推广应用，降低成本	中高：智能科技与护理的结合可以提升服务效率，但需解决技术普及问题

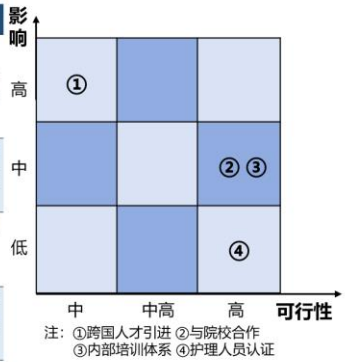


资料来源：从容应队整理

人才来源多元化虽然在短期内可能面临文化差异、培训成本等问题，但从长期来看，通过与院校合作、引入跨国人才和内部培训体系，企业可以逐步缓解人才短缺问题，提高护理人员的专业水平。

图51：人才来源多元化风险矩阵与可行性探讨

因素	风险	影响程度	风险应对措施	可行性分析
跨国人才引进	跨国招聘难度大，文化差异影响工作效率，语言障碍导致沟通问题	高	提供跨文化培训，建立多语言沟通机制，提供具有吸引力的薪酬和福利	中：跨国人才引进需要投入大量资源，但在高端护理领域有较大潜力
与院校合作	培养周期较长，短期内难以解决人才紧缺问题	中	提前与职业院校合作，提供实习机会，建立长期人才输送机制	高：与院校合作可持续性强，能够为企业提供稳定的人才来源
内部培训体系	培训成本高，效果难以量化，现有员工流失率高	中	制定清晰的职业发展路径，提供晋升机会，设计激励机制	高：内部培训可以有效提升现有人员的技能，降低人才流失率
护理人员认证	认证门槛提高可能导致部分人员流失，增大招聘成本	低	分层次设立认证标准，逐步提高要求，激励员工持续学习	高：认证体系可以提升服务质量，增加企业竞争力

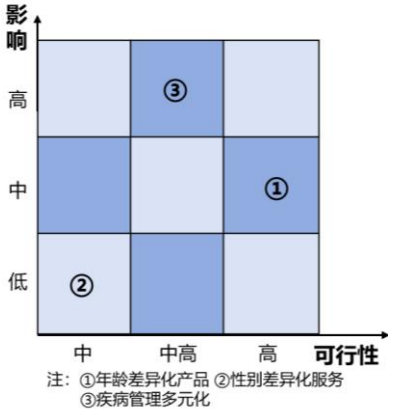


资料来源：从容应队整理

服务产品多元化的可行性较高，尤其是在年龄差异化和疾病管理方面，市场潜力大且能够满足老年人群体的个性化需求。性别差异化服务的市场需求需进一步验证，但通过试点项目逐步推广可以有效降低风险。服务产品多元化是提升企业竞争力的重要手段，需谨慎控制成本。

图52：服务产品多元化风险矩阵与可行性探讨

因素	风险	影响程度	风险应对措施	可行性分析
年龄差异化产品	产品设计复杂，难以精准匹配每个年龄段的需求，增加成本	中	开展用户调研，根据需求细分市场，按需定制服务套餐	高：通过市场调研和大数据分析，可精准匹配不同年龄段的需求
性别差异化服务	性别差异化需求较难标准化，可能导致成本增加且市场需求不明确	低	通过试点项目检验性别差异化产品的市场反应，逐步扩大服务覆盖	中：试点项目可以降低风险，但全面推广需根据市场反馈调整
疾病管理多元化	针对慢病和阿尔茨海默症等疾病的护理成本较高，市场需求分散	高	与医疗机构合作，研发针对特定疾病的护理方案，优化护理流程	中高：与医疗机构合作可以降低风险，但开发新产品需要较多资源

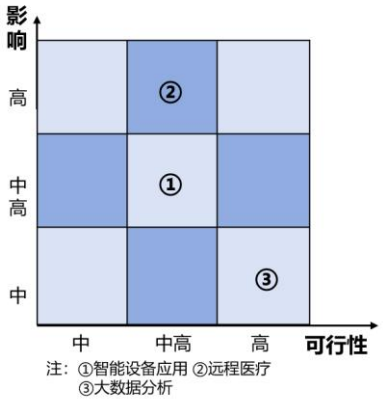


资料来源：从容应队整理

技术创新多元化具有较高的可行性，但技术开发成本较高且需持续投入，且数据隐私问题需要格外重视。远程医疗的法律和伦理问题也可能对推广产生一定的阻碍，但总体上技术创新的应用潜力巨大，前景可期。

图53：技术创新多元化风险矩阵与可行性探讨

因素	风险	影响程度	风险应对措施	可行性分析
智能设备应用	技术开发成本高，设备更新换代快，难以掌握老年人对技术的接受度	中高	提供技术培训，简化设备使用界面，定期进行市场调研和技术升级	中高：技术迭代快，需要持续投入资金，但可提升服务质量和效率
远程医疗	远程医疗服务的法律和伦理问题复杂，数据隐私和安全性风险大	高	完善法律合规体系，确保数据安全全，采用加密技术保护隐私	中高：技术可行性高，但法律和隐私问题需要严格监管和保障
大数据分析	数据收集和分析成本高，数据准确性和隐私保护存在挑战	中	与技术公司合作，使用先进的数据加密和匿名化处理技术，确保数据安全	高：大数据分析有助于精准护理服务，但需要完善隐私保护和数据管理

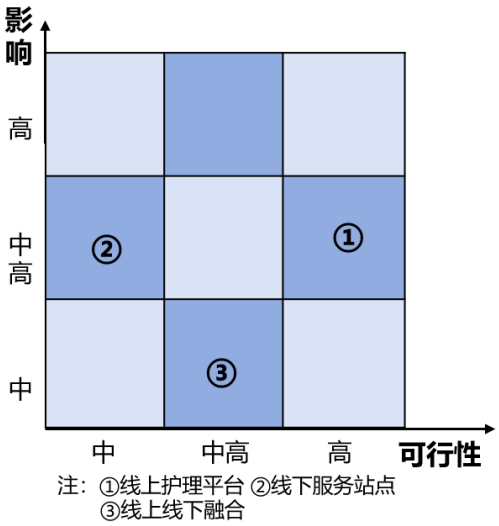


资料来源：从容应队整理

服务渠道多元化具有较高的可行性，尤其是通过线上平台和线下服务站点的结合，可以扩大服务范围并提升服务的便捷性。然而，老年人对线上平台的接受度和线下站点的建设成本是主要风险点。通过提供技术支持、简化平台使用方式，并优化资源配置，企业可以有效应对这些挑战。线上线下融合的管理复杂性需要通过统一的管理系统加以解决。

图54：服务渠道多元化风险矩阵与可行性探讨

因素	风险	影响程度	风险应对措施	可行性分析
线上护理平台	老年人对线上平台的适应度较低，平台开发和维护成本高	中	提供简单易用的界面，针对老年人提供专门的技术支持和培训	高：线上平台可以扩大服务范围，提升护理服务的便捷性，但需教育推广
线下服务站点	建设成本高，维护费用较大，难以覆盖所有社区	中高	选择覆盖老年人密集的区域，逐步扩展站点覆盖范围，优化资源配置	中：建设成本高，但可提升社区服务的可及性，需逐步推广实施
线上线下融合	多渠道服务的协调与管理复杂，可能导致服务不一致或资源浪费	中	建立统一的管理系统，确保线上线下服务的无缝衔接，优化服务流程	中高：线上线下融合可以提升服务灵活性，但需加强管理和流程优化



资料来源：从容应队整理

通过运作风险矩阵和可行性探讨可以看出，多元化战略总体上可行性较高。可以通过合理的风险管理策略，逐步推进实施，以期提升企业的竞争力和服务质量。

本研究通过对中国老年护理行业的深入分析，揭示了行业在政策、市场、文化和技术等多方面的机遇与挑战。通过对行业痛点的梳理和供需现状的探

讨，本研究发现老年护理行业不仅是养老和大健康产业的交汇点，还承载着社会、家庭和市场多重责任的融合。研究表明，未来在政策支持、供给侧改革和商业化创新的推动下，**老年护理行业必将在差异化发展中释放巨大的潜力。**与此同时，**护理人才的培养、孝道文化的传承与现代护理服务的融合**，也将成为推动行业持续发展的关键因素。

然而，老年护理不仅关乎经济，更关乎人文。它既是产业发展的新风口，也是对老年人尊严与晚年幸福的终极关怀。本研究坚信，在各方共同努力下，老年护理行业将迎来更加光明的未来。正如本研究的研究题目所言，**虽为“夕阳”产业，却充满“朝阳”之机。**本研究“从容应队”也衷心希望，**所有老年人都能够从容应对老年生活，在温暖与关爱的陪伴中，度过充实而有尊严的晚年。**

参考文献：

[1]Harper, S. (2014). Economic and social implications of aging societies. Science, 346(6209), 587-591.https://doi.org/10.1126/science.1254405

[2]McMaughan, D. J., Oloruntoba, O., & Smith, M. L. (2020). Socioeconomic Status and Access to Healthcare: Interrelated Drivers for Healthy Aging. Frontiers in Public Health, 8, Article 231. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00231

[3]Fang, E. F., Scheibye-Knudsen, M., Jahn, H. J., Li, J., Ling, L., Guo, H. W., Zhu, X. Q., Preedy, V., Lu, H. M., Bohr, V. A., Chan, W. Y., Liu, Y. L., & Ng, T. B. (2015). A research agenda for aging in China in the 21st century. Ageing Research Reviews, 24, 197-205. https://doi.org/10.1016/j.arr.2015.08.003

[4]Fang, E. F., Xie, C. L., Schenkel, J. A., Wu, C. K., Long, Q., Cui, H. H., Aman, Y., Frank, J., Liao, J., Zou, H. C., Wang, N. Y., Wu, J., Liu, X. T., Li, T., Fang, Y., Niu, Z. M., Yang, G., Hong, J. S., Wang, Q., . . . Woo, J. (2020). A research agenda for ageing in China in the 21st century (2nd edition): Focusing on basic and translational research, long-term care, policy and social networks. Ageing Research Reviews, 64, Article 101174. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101174

[5]彭希哲,陈倩.中国银发经济刍议[J].社会保障评论,2022,6(04):49-66.

[6]吴敏.基于需求与供给视角的机构养老服务发展现状研究[D].山东大学,2011.

[7]代志新, 杜鹏, & 董隽含. (2023). 中国老年抚养比再估计与人口老龄化趋势再审视. 人口研究, 47(3), 94-107.

[8]胡宏伟,李延宇,张澜.中国老年长期护理服务需求评估与预测[J].中国人口科学,2015,(03):79-89+127.

[9]黄佳豪,孟昉.“医养结合”养老模式的必要性、困境与对策[J].中国卫生政策研究,2014,7(06):63-68.

[10]赵晓芳.健康老龄化背景下“医养结合”养老服务模式研究[J].兰州学刊,2014,(09):129-136.

[11]张晓杰.医养结合养老创新的逻辑、瓶颈与政策选择[J].西北人口,2016,37(01):105-111.DOI:10.15884/j.cnki.issn.1007-0672.2016.01.018.

[12]穆光宗.我国机构养老发展的困境与对策[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,51(02):31-38.

[13]郑佳映,张英,陈雪萍,等.293 名养老机构养老护理员组织承诺和职业环境相关性分析[J].护理学报,2019,26(24):28-31.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2019.24.028.

[14]孟润堂,胡樱,宇传华,等.我国老年护理发展现状与护理人员老年护理从业意愿研究进展[J].中国全科医学,2015,18(15):1791-1796.

[15]李春玉,刘姝,陈宏吉.试论我国老年护理现状和发展方向[J].护理学杂志,2014,29(03):1-3.

[16]李洁,徐桂华,姜荣荣,等.我国养老护理服务人员现状及人才培养展望[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2012,13(04):236-239.

[17]李建伟,吉文桥,钱诚.我国人口深度老龄化与老年照护服务需求发展趋势[J].改革,2022,(02):1-21.

[18]王桂新，千一慧. (2017). 中国的人口老龄化与区域经济增长. 中国人口科学, 2017(3), 30-42.